

小児の消化管疾患

2026年3月10日

名古屋市立大学医学部 小児科

伊藤彰悟

小児消化器？



一般社団法人

日本小児栄養消化器肝臓学会

JSPQHAN

Japanese Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

 会員専用ページ

[ホーム](#)

[学会について](#) ▾

[学術集会](#) ▾

[学会雑誌・刊行物](#) ▾

[診療ガイドライン・指針](#)

[セミナー](#) ▾

[認定医制度](#)

[入会・登録情報](#)

こどもたちの
心とからだに栄養を

Go Together with Every Child and
Pediatric Gastroenterologists !



今日の内容

急性胃腸炎

虫垂炎

解剖学的異常・通過障害

- ・ 腸回転異常症
- ・ メッケル憩室
- ・ 鎖肛

機能的消化管疾患

- ・ 周期性嘔吐症
- ・ 便秘症
- ・ ヒルシュスプルング病

腸重積症

小児消化管感染症 診療ガイドライン

監修

日本小児感染症学会

日本小児消化管感染症・免疫アレルギー研究会

2024



急性胃腸炎

<概念>

ウイルス・細菌感染により発症。

多くは

<症状>

など。

ウイルス性腸炎では水様性頻回の下痢。

細菌性腸炎では便性は泥状で粘膿性、ときに腐敗臭、血便を伴う。

乳幼児では重症化しやすい。脱水、けいれんなど。

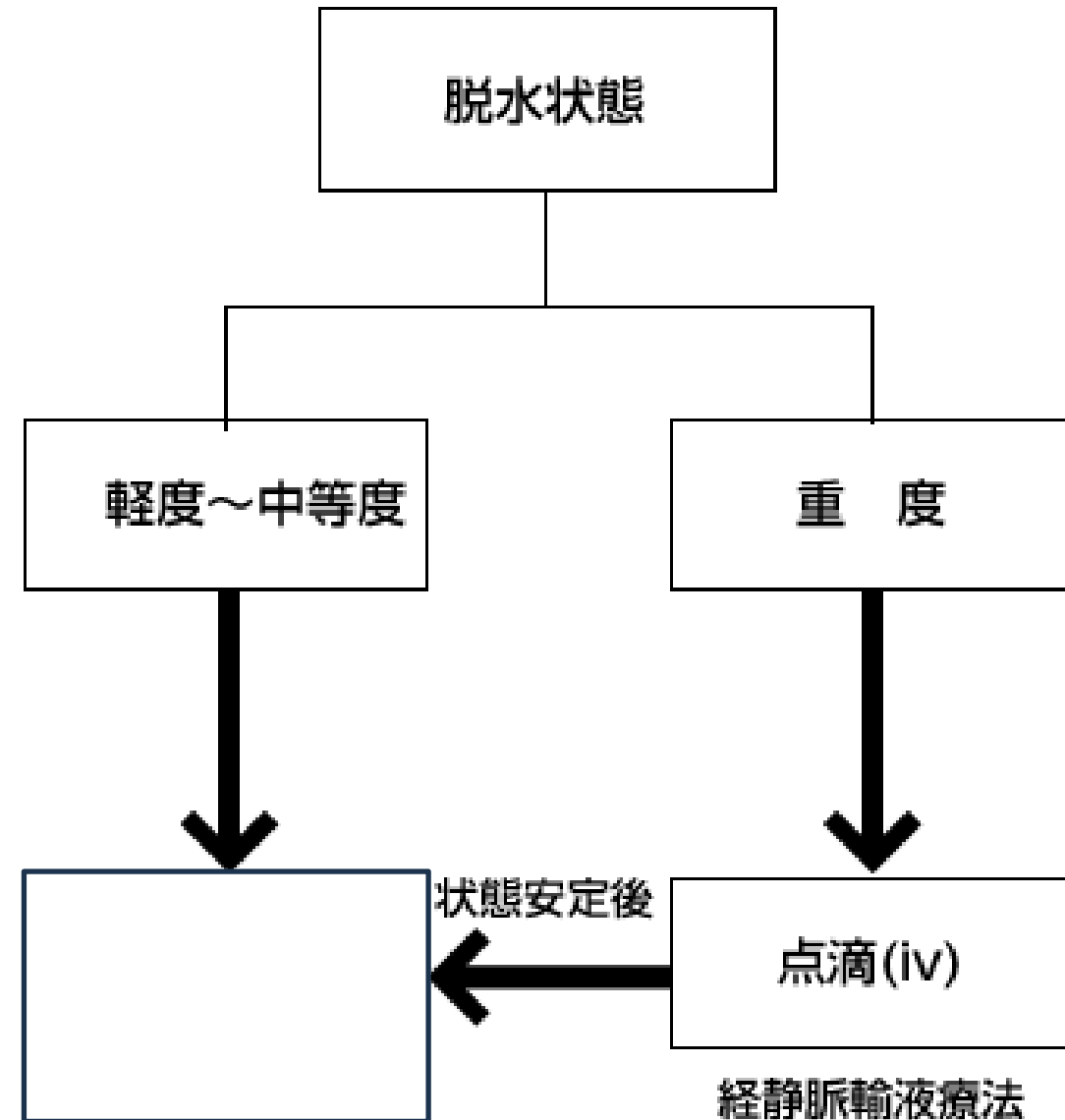
急性胃腸炎

<診断>

- 便中抗原検査
- 便培養検査

<治療>

-
- 重度脱水は輸液療法



小児の脱水の重症度評価

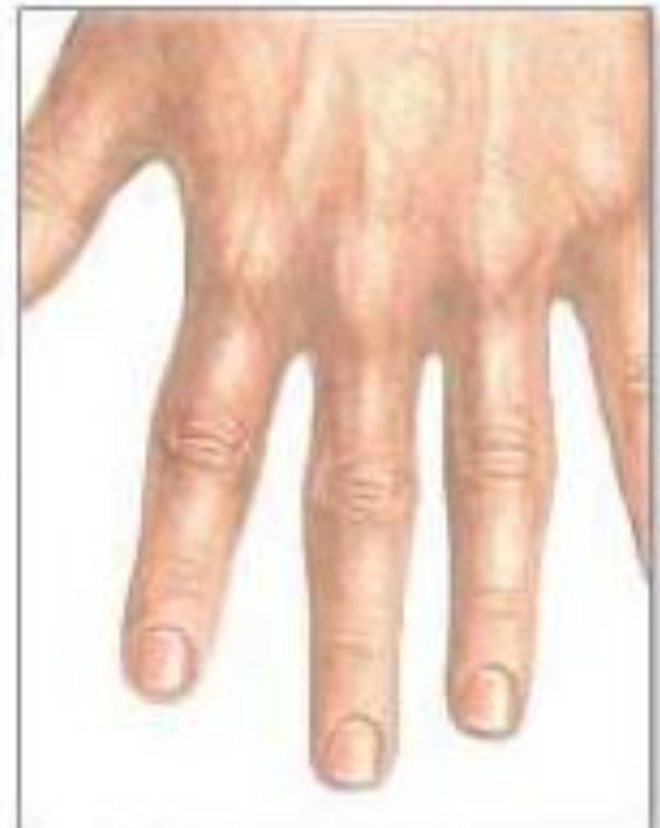
症状	軽～中等度 3～9%の体重減少	重度 9%以上の体重減少
心拍数	増加	頻脈
呼吸	正常または速い	深い
眼窩	やや陥凹	著しく陥凹
涙	減少	出ない
口腔粘膜	乾燥	著しく乾燥
皮膚のしわ	2秒未満でもどる	2秒以上でもどる
毛細血管 再充満時間	延長	延長
四肢	冷たい	冷たい
尿量	減少	ほとんどない

毛細血管再充満時間 (Capillary refilling time)

爪を5秒間圧迫



圧迫解除



色が元に戻るまでの時間

> 秒 重度脱水

推奨される経口補水液と 主なイオン飲料の組成

	Na (mEq/l)	K (mEq/l)	Cl (mEq/l)	Glucose (%)	浸透圧 (mOsm/L)
WHO推奨	75	20	65	1.35	245
ESPGHAN推奨	60	20	—	1.3-2.0	200-250
AAP推奨	40-60	20	—	2.0-2.5	—
OS-1®	50	20	50	1.8	260
ポカリスエット®	21	5	16	6.2	326
アクエリアス®	11	5	—	4.7	260

家庭でつくる経口補水液

水 1リットル

砂糖 40 g (砂糖 大さじ4杯と半分)

食塩 3 g (食塩 小さじ半分)

果汁 少量



家庭でつくる経口補水液

水 1リットル

砂糖 40 g (砂糖 大さじ4杯と半分)

食塩 3 g (食塩 小さじ半分)

NaClの分子量：58.44 g/mol

NaCl 1 g = $1/58.44$ mol = $1000/58.44$ mmol

NaCl 3 g = 51.2 mmol

危険信号（ Red Flag ） 1

1. 見た目に調子が悪そう、もしくは だんだん調子が悪くなる	重症脱水を示唆
2. ちょっとした刺激に過敏に反応する、 反応性に乏しいなどの反応性の変化	重症脱水を示唆
3. 目が落ちくぼんでくる	重症脱水を示唆
4. 頻脈	重症脱水を示唆
5. 多呼吸	重症脱水を示唆
6. 皮膚緊張（ツルゴール）の低下	重症脱水を示唆
7. 手足が冷たい、もしくは網状チアノーゼ	重症脱水を示唆
8. 持続する嘔吐※	今後脱水が進行する可能性
9. 大量の排便	今後脱水が進行する可能性

※NICEガイドラインでは「直前の24時間で3 回以上の嘔吐」

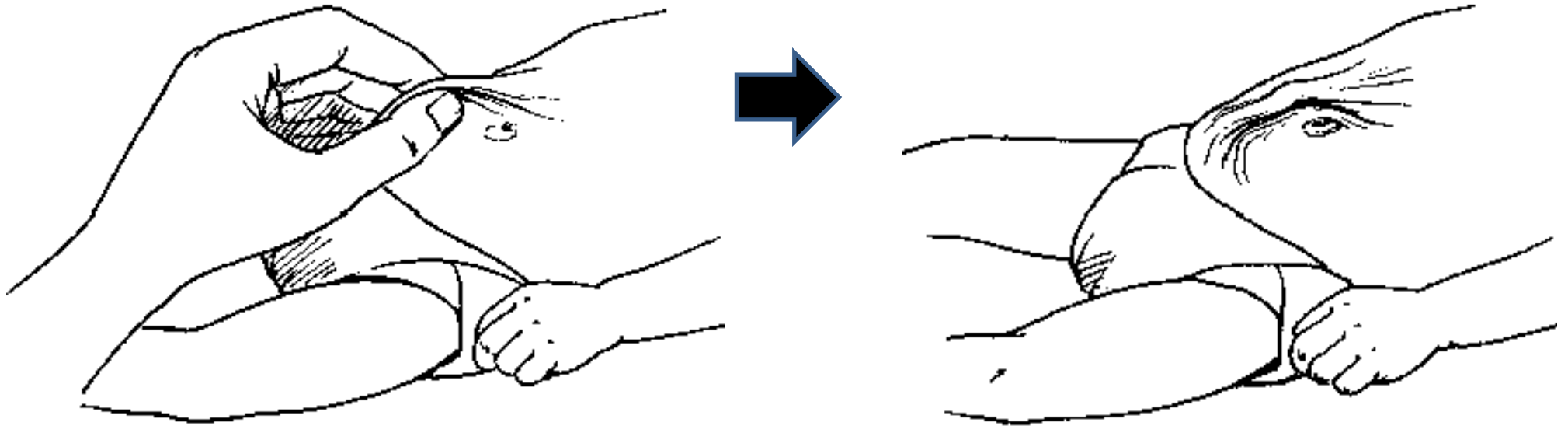
落ちくぼんだ目



Sunken eyes

Pocket book of hospital care for children: Second edition

皮膚ツルゴールの低下



腹部の皮膚を指でつまんで、離したとき、
皮膚のシワの戻りが遅い（ ≥ 2 秒）

危険信号（ Red Flag ） 2

10. 糖尿病、腎不全、代謝性疾患などの基礎疾患がある	通常とは異なる配慮が必要
11. 生後2か月未満	通常とは異なる配慮が必要
12. 生後3か月未満の乳児の38℃以上の発熱	胃腸炎以外の疾患を示唆
13. 黄色や緑色の胆汁性嘔吐、もしくは血性嘔吐	胃腸炎以外の疾患を示唆
14. 反復する嘔吐の既往	胃腸炎以外の疾患を示唆
15. 間欠的腹痛	胃腸炎以外の疾患を示唆
16. くこの字に体を折り曲げる、痛みで泣き叫ぶ、もしくは歩くと響くなどの強い腹痛	胃腸炎以外の疾患を示唆
17. 右下腹部痛、特に心窩部・上腹部から右下腹部に移動する痛み	胃腸炎以外の疾患を示唆
18. 血便もしくは黒色便	胃腸炎以外の疾患を示唆

胆汁性嘔吐

緑色：胆汁の色→重篤な疾患の疑い



下血



鮮血便：の出血



暗赤色便：の出血



タール便：の出血

CQ7

軽度～中等度の脱水のある小児急性胃腸炎に対する初期治療として、どのように経口補水液を投与することが推奨されるか？

推奨

軽度～中等度の脱水のある小児急性胃腸炎に対する初期治療として、**4時間以内に不足分の水分を経口補水液で経口摂取**することが推奨される。(1-C)

**強い
推奨**



経口補水プロトコール（例）

初期補液	50 mL/kgの経口補水液を 4時間かけて少量頻回に投与する	
維持療法	体重（Kg）	1日あたりの経口補水液投与量
	0～10	mL/kg
	10～20	1000 mL + mL × [体重（kg） - 10]

CQ8

嘔吐症状がある小児急性胃腸炎に対して経口補水療法は推奨されるか？



推奨

嘔吐症状がある小児急性胃腸炎に対しても経口補水液による経口補水療法は推奨される。

(2-B) **弱い
推奨**

CQ9

経口補水液摂取を嫌がる小児急性胃腸炎患児に対して、代替策として経口補水液以外の飲料摂取は推奨されるか？

推奨

経口補水液を嫌がって十分な量が摂取できない場合には、明らかな脱水所見がなければ、**経口補水液以外の水分を摂取してもよい。**

ただし、脱水兆候や意識レベルの変調が認められた場合には速やかに医療機関を受診するべきである。
(2-C)

弱い
推奨



CQ10

急性胃腸炎の乳児に対して母乳栄養は継続してよいか？



推奨

急性胃腸炎の乳児に対して**母乳栄養は継続してよい**。経口補水液による脱水補正中であっても、母乳を併用したほうが重症脱水が少ないというエビデンスがあり、むしろ**積極的に母乳栄養を継続すべき**である。（1-B）

**強い
推奨**

CQ11

急性胃腸炎の小児に対してミルクや食事を早期に開始してよいか？



推奨

経口補水療法によって**脱水が補正されればミルクや食事は早期に開始してよく、長時間の食事制限は推奨されない**。食事の内容も年齢に応じた通常の食事であり、食事制限をしても治癒までの期間に変わりはなく、むしろ体重の回復を遅らせる可能性がある。（1-A）

**強い
推奨**

CQ12

急性胃腸炎の乳児に
対してミルクは希釈
しないほうがよいか
？

推奨

**ミルクは希釈しないことを推奨
する。**ミルクを希釈しても治癒
までの経過に利点はない。

(1-A)

**強い
推奨**

CQ13

急性胃腸炎の小児に
対して不適切な食事
はあるか？

推奨

エビデンスは十分ではないが、
**高脂肪の食事や糖分が多い飲料は
避ける**ことが推奨される。

(2-C) **弱い
推奨**



CQ15-1

急性胃腸炎の小児に対して整腸薬プロバイオティクスは有効か？

推奨

プロバイオティクスは下痢の期間を短縮する。ただし、エビデンスのある薬剤は、本邦で販売されているものと菌種や菌量が異なっている。（2-B）

弱い
推奨

CQ15-2

急性胃腸炎の小児に対して止痢薬・止瀉薬は有効か？

推奨

止痢薬・止瀉薬の使用は推奨されない。止痢薬については有効とのエビデンスが乏しい。止瀉薬（ロペラミド）は乳児でイレウスの発症が報告され、6か月未満は禁忌、**2歳未満は原則禁忌**となっている。（1-B：使用しないことを強く推奨する）

強い
推奨

ロタウイルス腸炎

- にかけて流行。

- 経口感染。
- 感染力が強い。

<症状>

- 潜伏期は1-2日。嘔吐に始まり、水様下痢（白色）が続く。発熱することもある。乳幼児では症状が強い。
- 数日から1週間で軽快。

<診断>

- 糞便の迅速診断キットを用いる。

<予防>



ロタウイルスワクチン

接種対象

- ・ 生後6週から生後24週の児

接種方法

- ・ 経口接種



重症ロタウイルス胃腸炎を予防する

2020年から定期接種

ノロウイルス感染症

<概念>

- に流行。
- 貝類、糞便・吐物から感染する。
感染力は非常に強い。

<症状>

- 潜伏期は1-2日。
- 症状は嘔吐、下痢、発熱。

<予防>

- ワクチンは無い。



消毒成分の有効性

成分	細菌	ノロ	ロタ
アルコール	○	×	×
次亜塩素酸 ナトリウム	○	○	○

細菌性腸炎

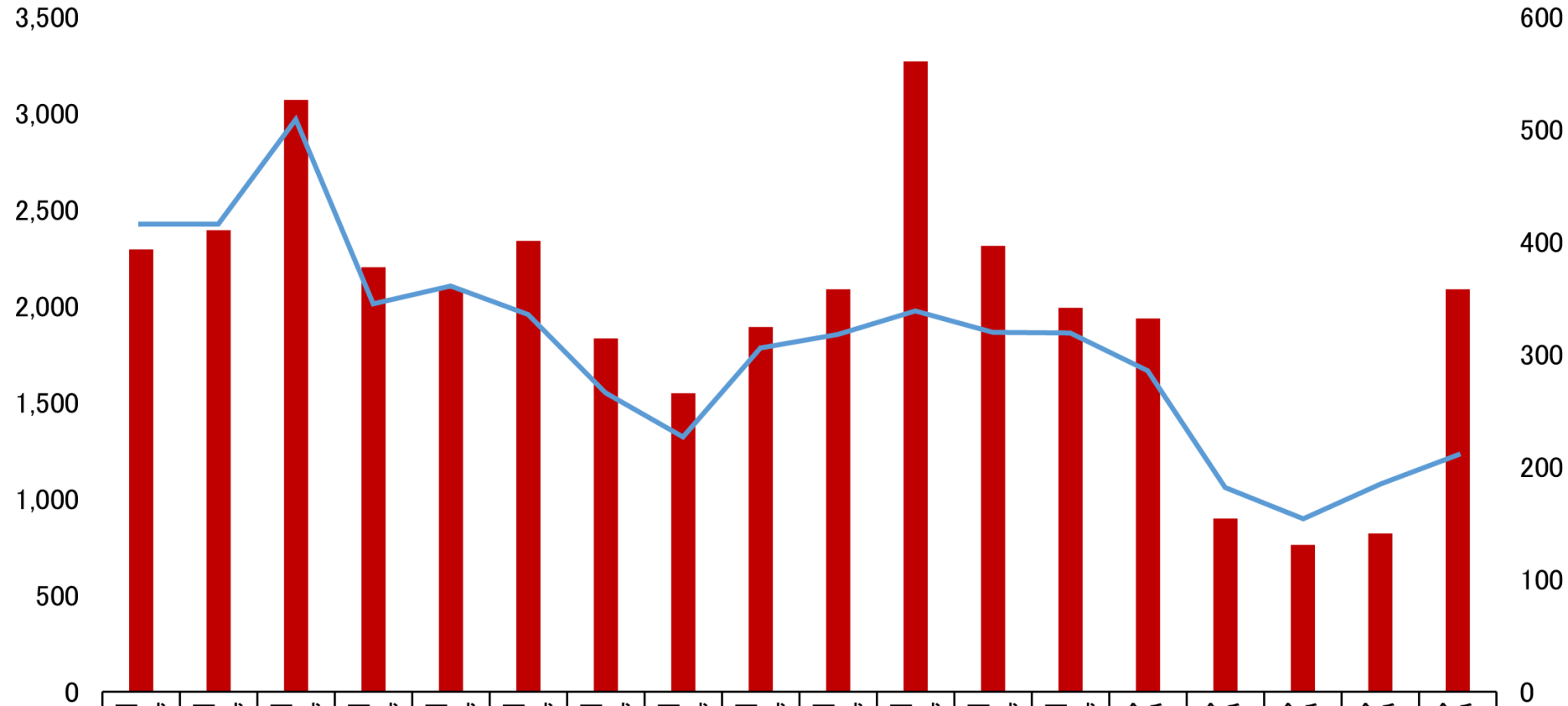
	カンピロバクター	サルモネラ	腸管出血性大腸菌
季節性	通年性	夏期に多い	夏期に多い
潜伏期間	2－5日	半日－2日	3－5日
主な原因食材			
臨床症状	下痢 (粘血便－水様便)	下痢 (粘血便－水様便)	下痢 (水様便→鮮血便)
	テネズムス	嘔吐、腹痛	テネズムス
	腹痛、嘔吐	発熱	腹痛
	発熱		微熱

細菌による食中毒件数では []が最多

患者数

[]食中毒の発生状況

件数



	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
患者数(人)	2,297	2,396	3,071	2,206	2,092	2,341	1,834	1,551	1,893	2,089	3,272	2,315	1,995	1,937	901	764	822	2,089
事件数(件)	416	416	509	345	361	336	266	227	306	318	339	320	319	286	182	154	185	211

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/campylobacterqa.html

カンピロバクター食中毒の予防

- 鶏肉は、高確率（20-100%）でカンピロバクターに汚染している。
- 鮮度は無関係。
- 十分に加熱して食べる。
- 鶏刺しや鶏のタタキは食べない。

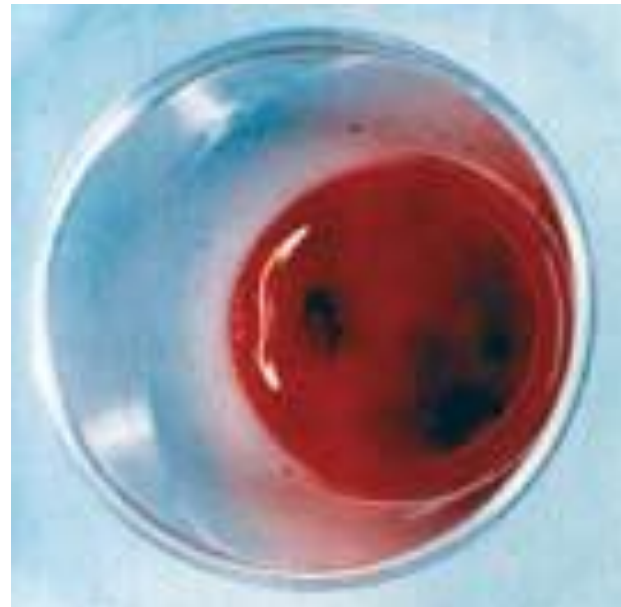
溶血性尿毒症症候群

hemolytic uremic syndrome : HUS

- 腸管出血性大腸菌（主にO157）により産生されるベロ毒素により、血管内皮細胞障害が起きる。
- 糸球体血管内皮細胞が傷害され、微小血栓形成が起き、、、が3主徴。
- 致死率約10%。
- 症候：乏尿、浮腫、出血斑、頭痛、傾眠、不穏、痙攣、血尿・蛋白尿など。

腸管出血性大腸菌感染症

- 牛肉や汚染された食材などから経口感染する。
- 少ない菌数で感染する。
- **ベロ毒素**を産生し、**出血性大腸炎**や**溶血性尿毒症症候群（HUS）**の原因となる。



今日の内容

急性胃腸炎

虫垂炎

解剖学的異常・通過障害

- ・ 腸回転異常症
- ・ メッケル憩室
- ・ 鎖肛

機能的消化管疾患

- ・ 周期性嘔吐症
- ・ 便秘症
- ・ ヒルシュスプルング病

腸重積症

急性虫垂炎

<症状>

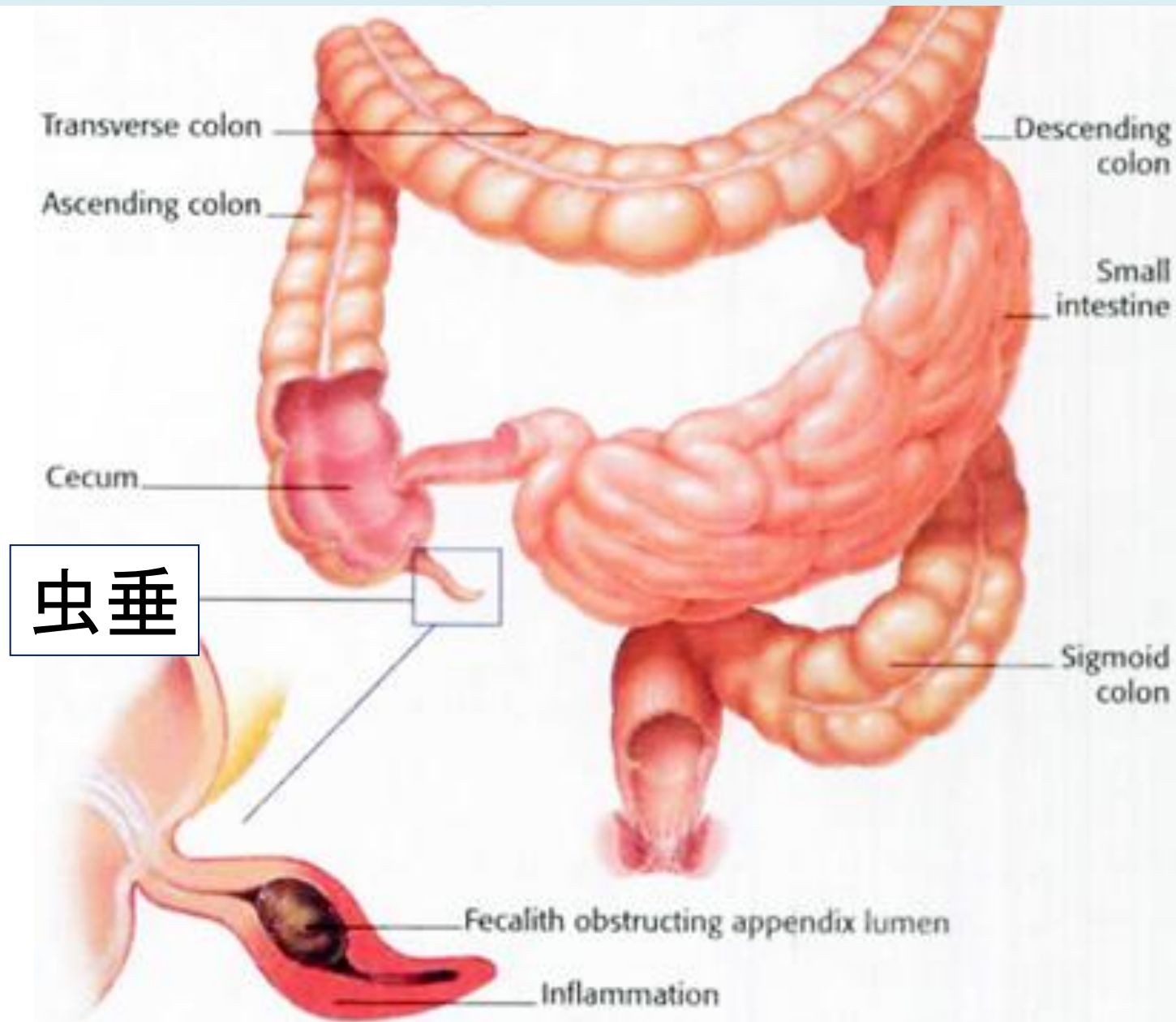
- 腹痛、嘔吐、発熱。

<診断>

- の圧痛、防御、痛。
- 血液検査：白血球増多や炎症反応高値。
- 腹部単純X線撮影：局所的の麻痺性イレウス像。
- 腹部超音波検査・CT：腫大した虫垂や壁構造の変化、糞石、周囲の炎症像、腹水や膿の貯留など。

<治療> 虫垂切除術

急性虫垂炎



虫垂炎は学童期に最も多い

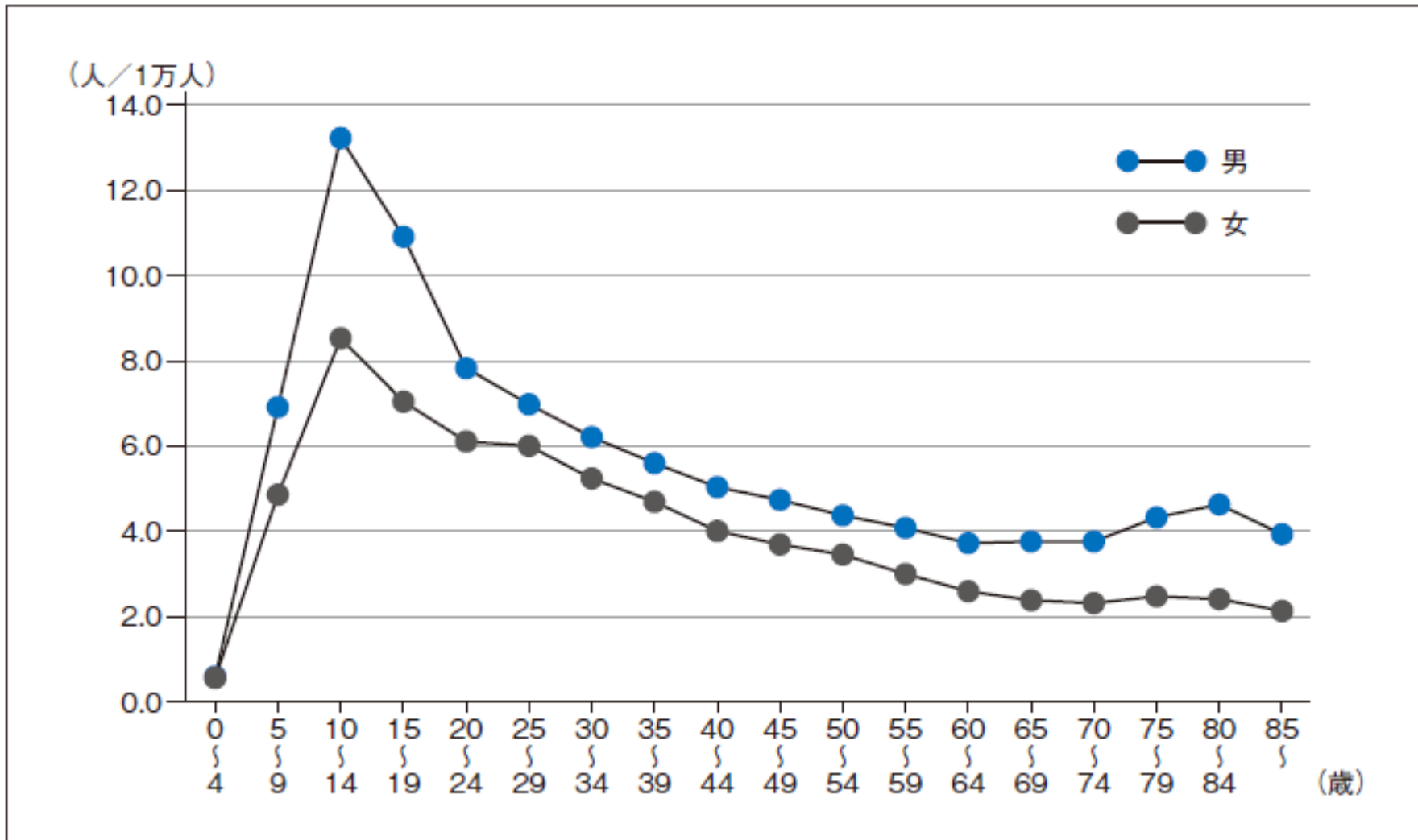


図4-1 1万人あたり年平均虫垂切除数 2011～2013年 NCDデータより

幼児期は穿孔率が高い

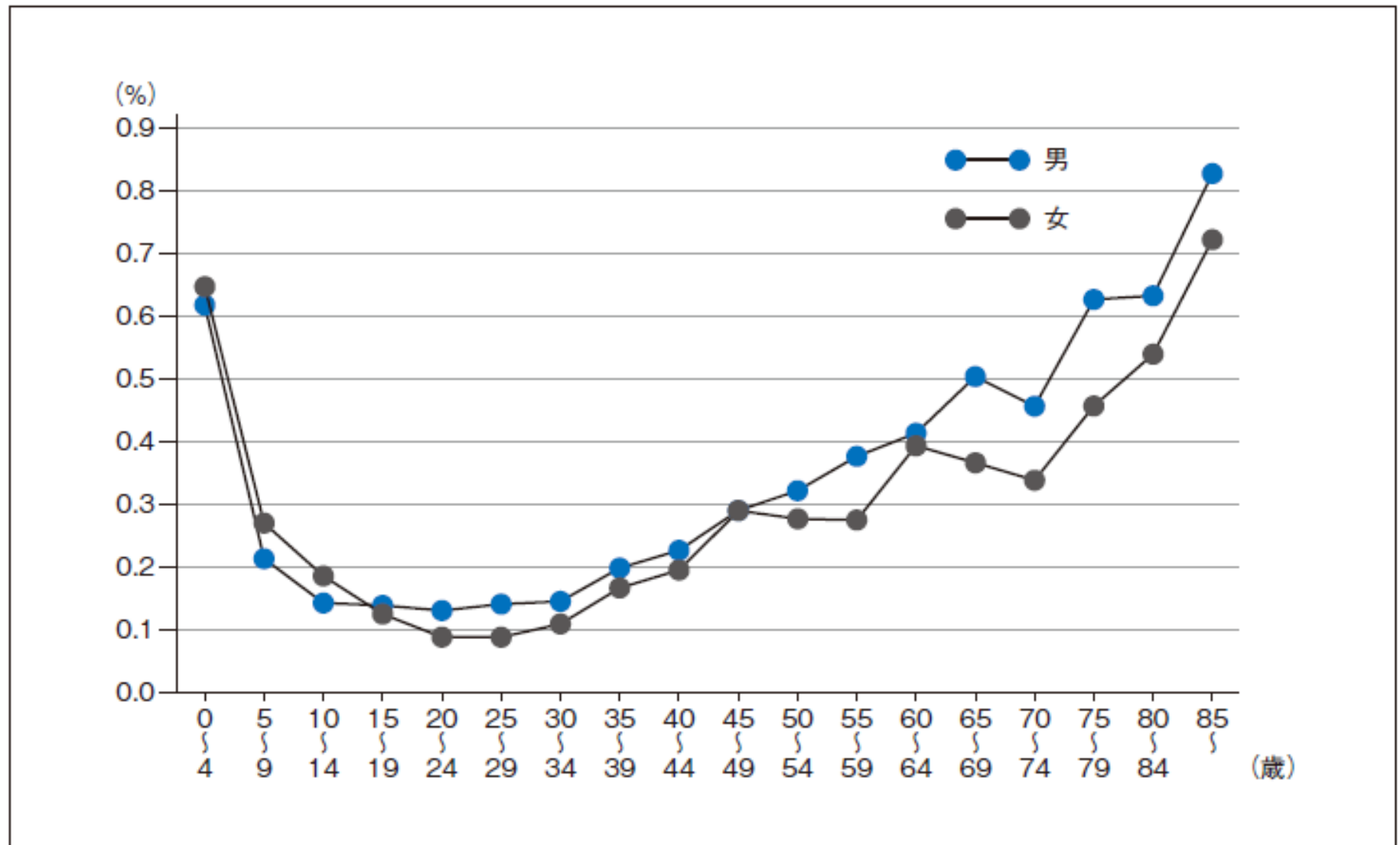
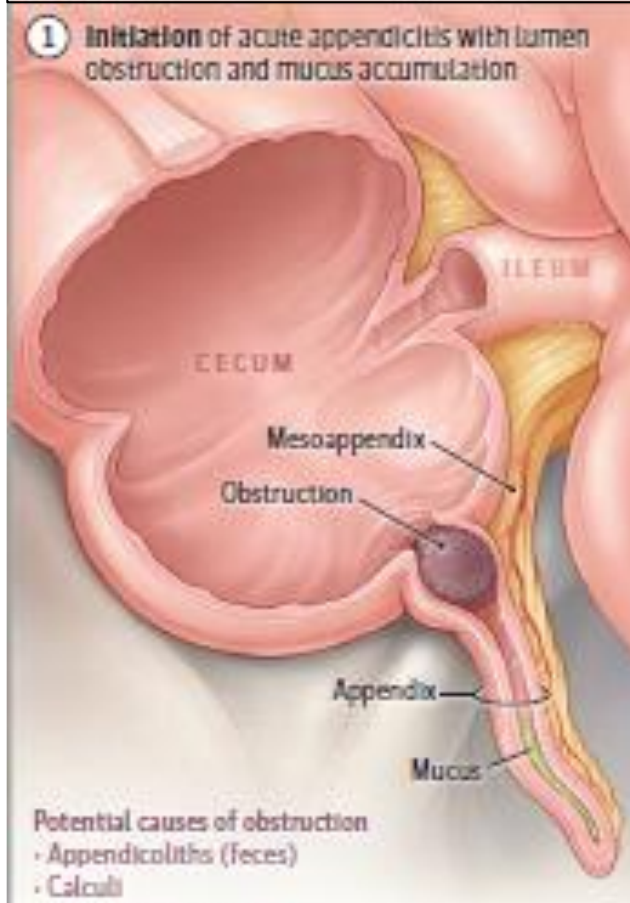


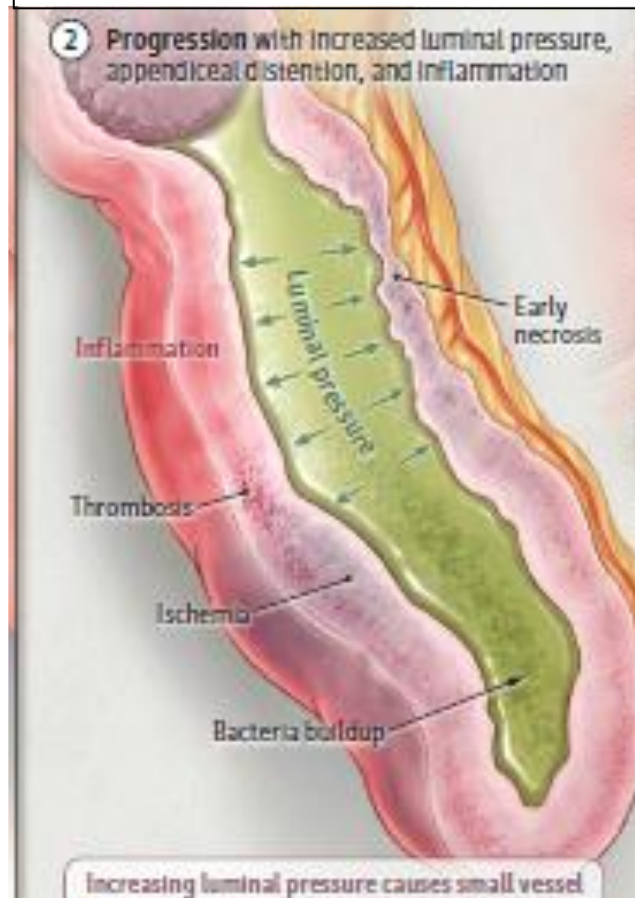
図4-5 汎発性腹膜炎手術／全虫垂切除術 2011～2013年 NCDデータより

急性虫垂炎の進行

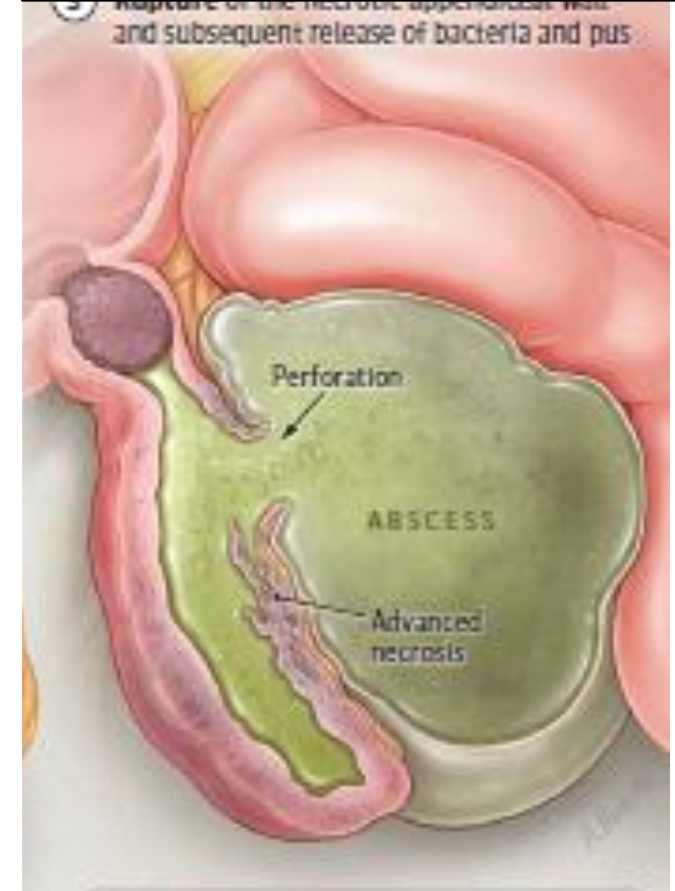
- 虫垂の閉塞
- 粘液の充満



- 虫垂径の拡大
- 壁の炎症と腫大



- 虫垂の穿孔
- 膿瘍形成



虫垂炎の痛みの変化

- 初期：

虫垂の閉塞による内圧の上昇

⇒心窩部や臍周囲に**局在のはっきりしない
鈍い痛み（内臓痛）**

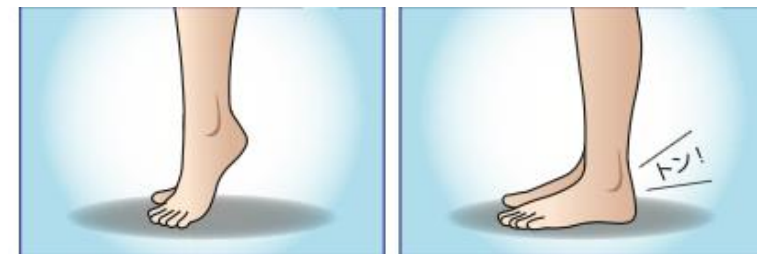
- 進行期：

炎症が壁側腹膜に波及

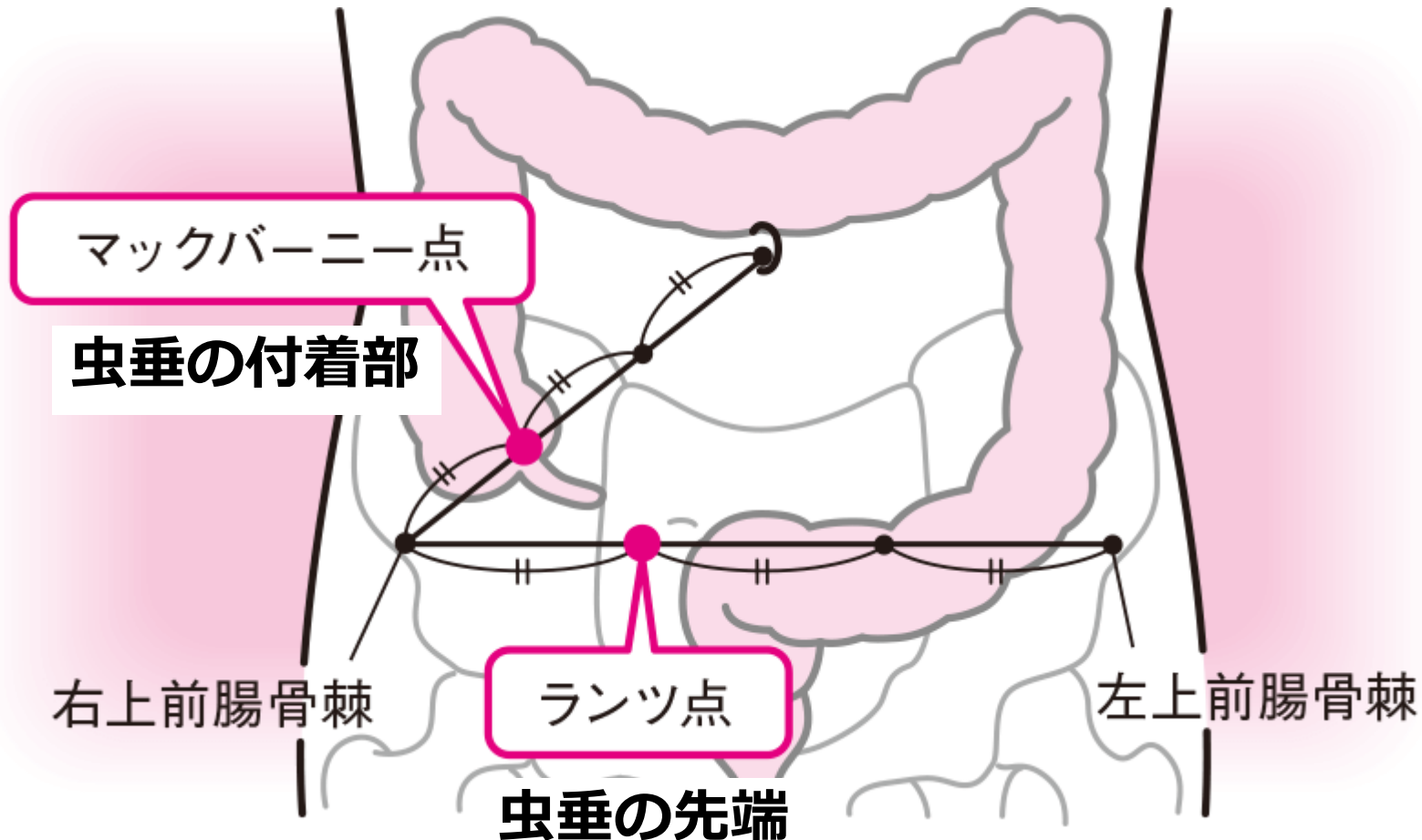
⇒**右下腹部に局在する鋭い痛み（体性痛）**

腹膜刺激症状

- **筋性防御**：「触診時に痛みを和らげようとして自分の意思で」腹筋に力をいれて防御する所見。
- **筋硬直**：腹壁の炎症部位の筋肉が「患者の意思にかかわらず」反射的収縮を起こして常に力の入った硬い状態となっていること。
- **反跳痛**：圧痛点付近を圧迫して急に放すと疼痛が増強する所見。
- **打診痛**
- Heel drop sign（踵落とし試験）
- 咳嗽試験



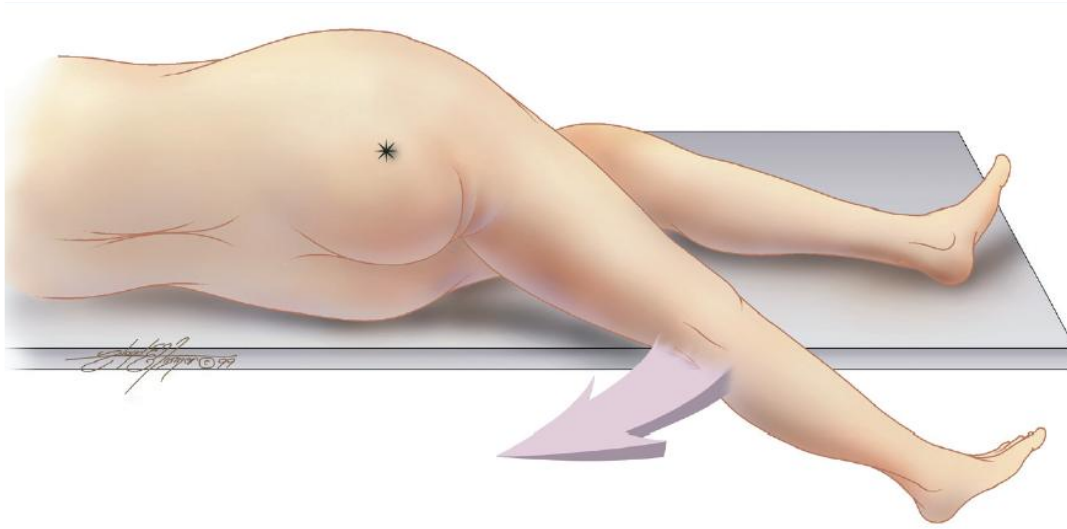
虫垂炎の圧痛点



Rosenstein徴候

左側臥位で右下腹部の圧痛が増強する徴候。

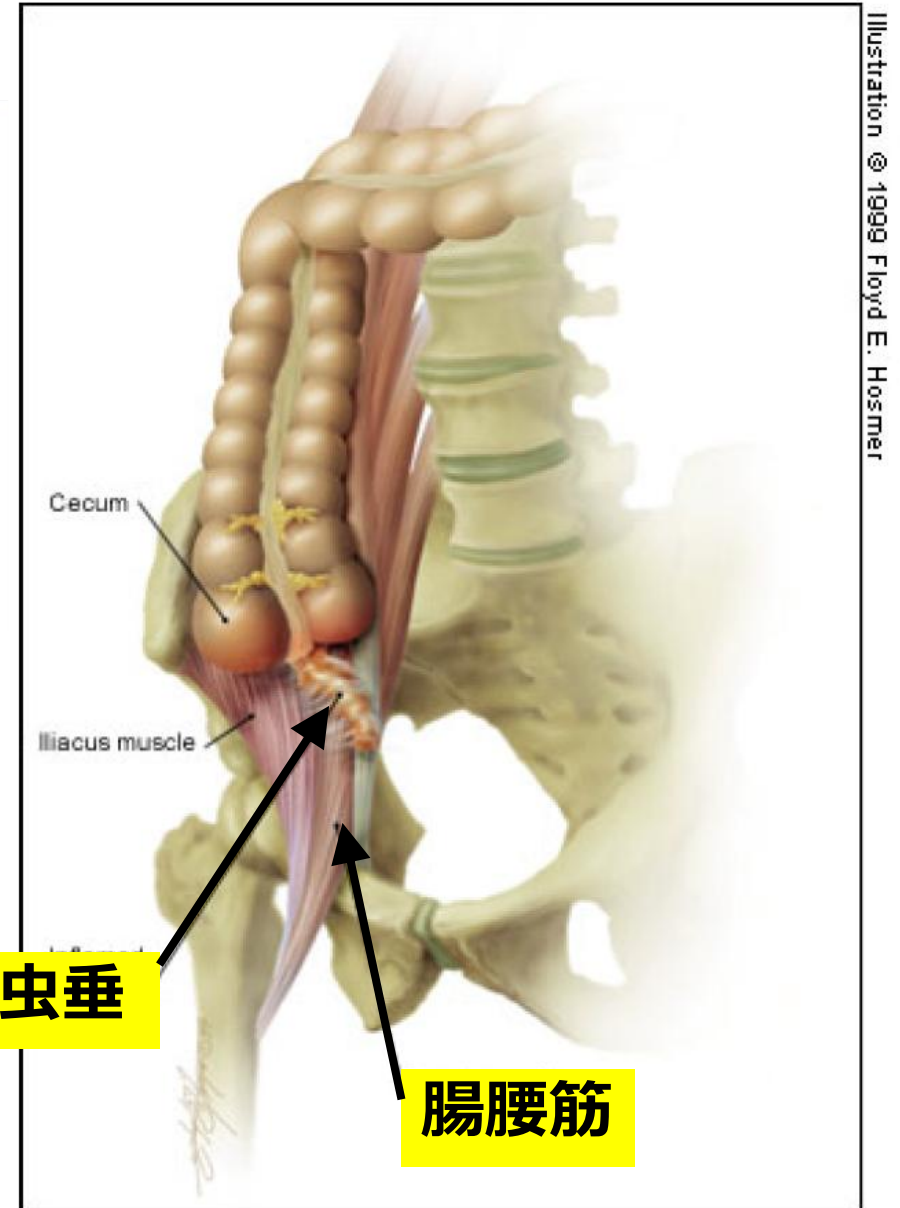
腸腰筋徴候



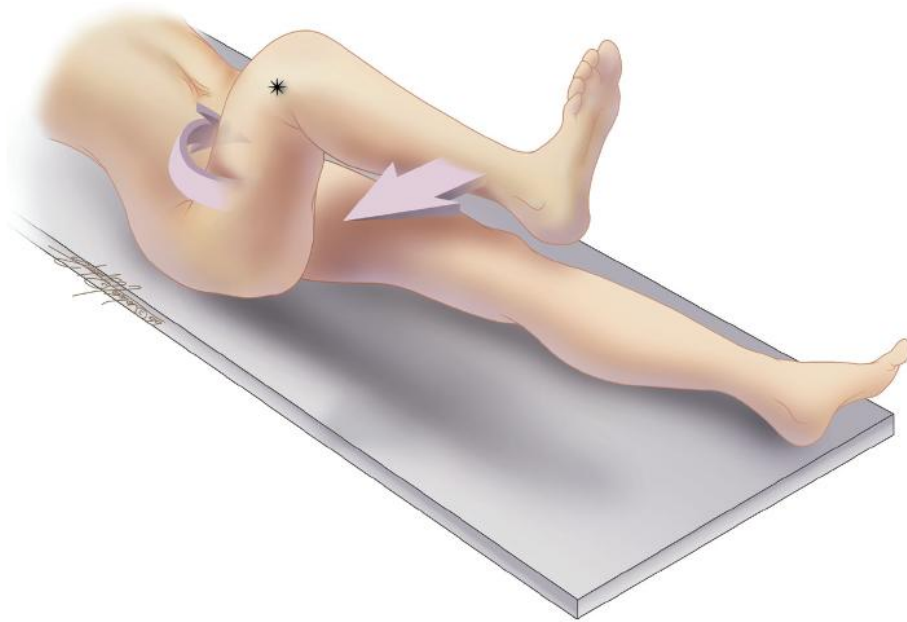
左側臥位で右下肢を伸展させたまま
股関節を過伸展させた時、
右下腹部に痛みが誘発される。

後腹膜の腸腰筋の炎症を示唆する。

Hardin DM Jr. Acute appendicitis: review and
update. Am Fam Physician. 1999 Nov 1;60(7):2027-
34. PMID: 10569505.

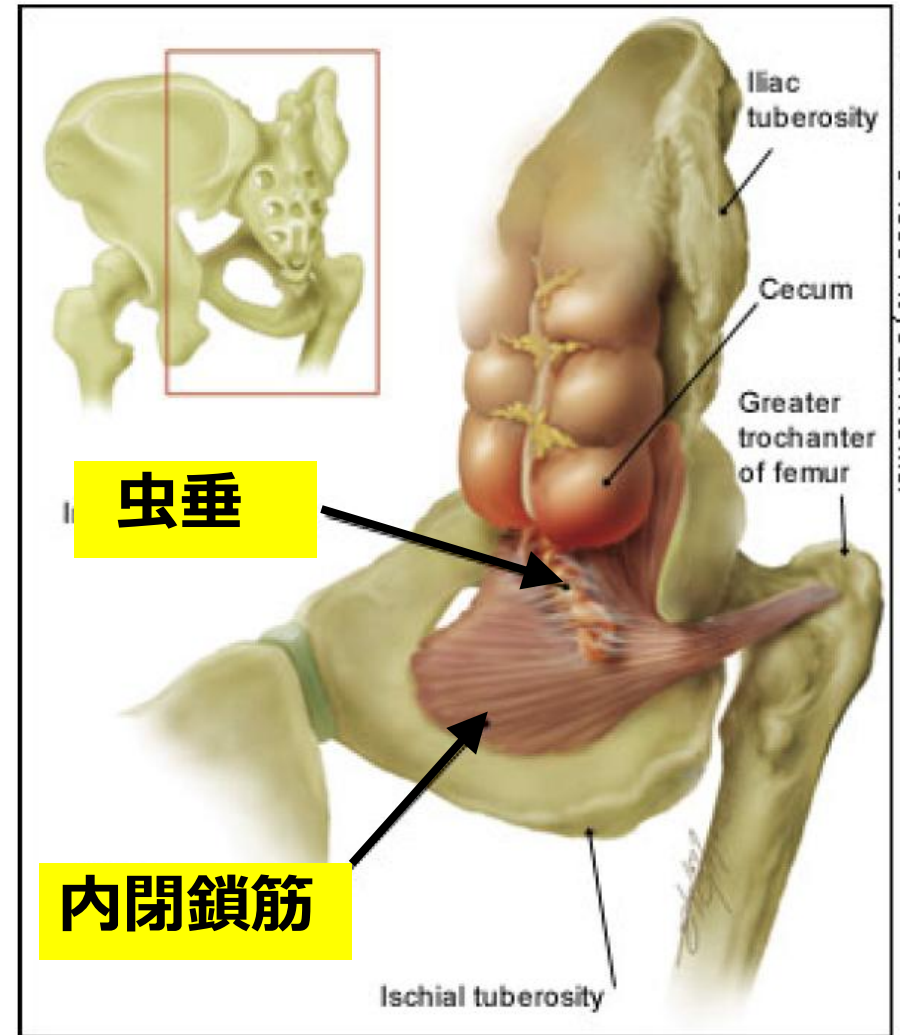


閉鎖筋徴候



右の腰と膝を屈曲させ、右腰部を内旋させると痛みが誘発される。

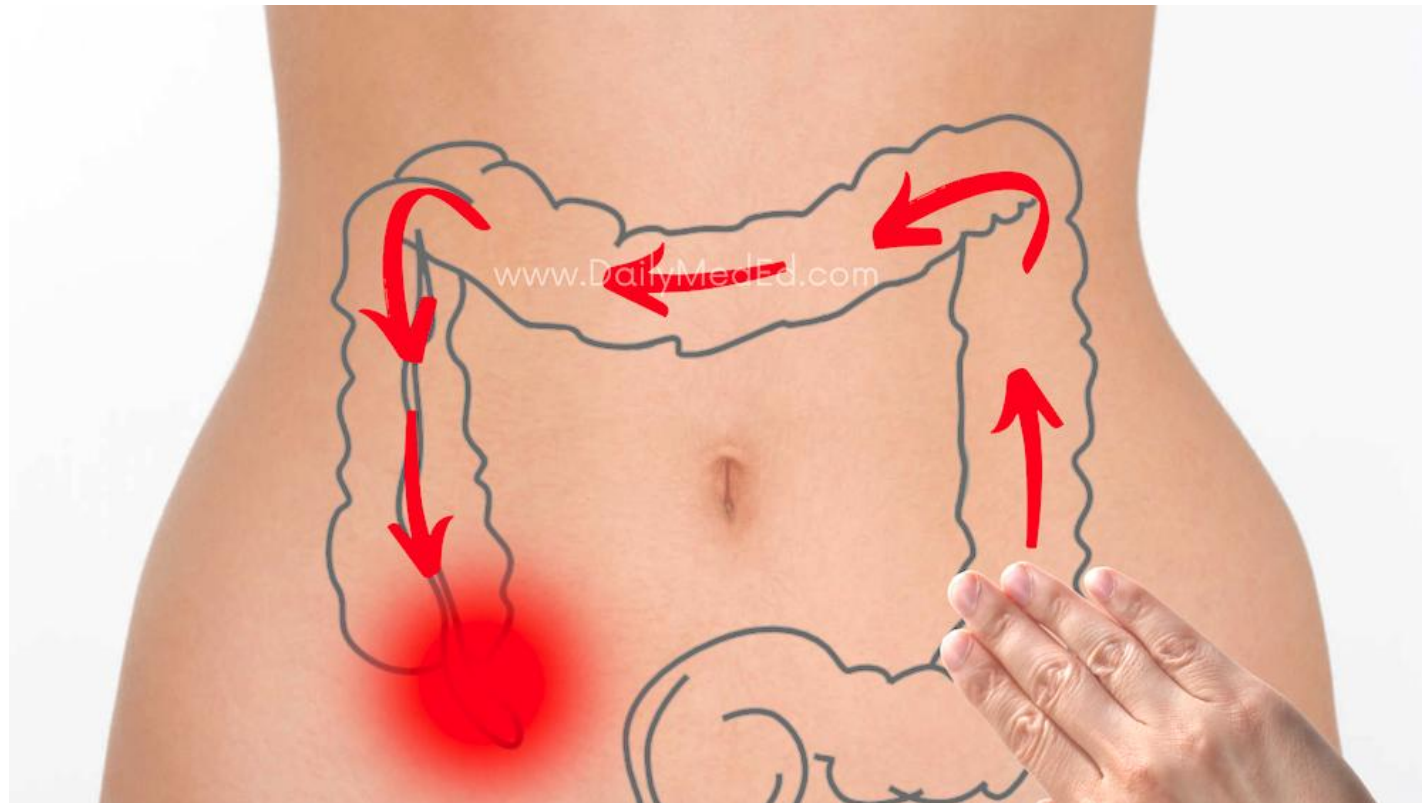
骨盤内の閉鎖筋の炎症を示唆する。



Hardin DM Jr. Acute appendicitis: review and update. Am Fam Physician. 1999 Nov 1;60(7):2027-34. PMID: 10569505.

Rovsing徴候

- 左下腹部の下行結腸を下方より上方へ押し上げるように圧迫すると回盲部が痛む徴候
- 腸管内のガスの回盲部への移動による。



スコアリング

Pediatric Appendicitis Score (PAS)

右下腹部に移動する痛み

1

右下腹部痛

2

咳・跳躍・打診による叩打痛

2

嘔気・嘔吐

1

食欲不振

1

発熱（38℃以上）

1

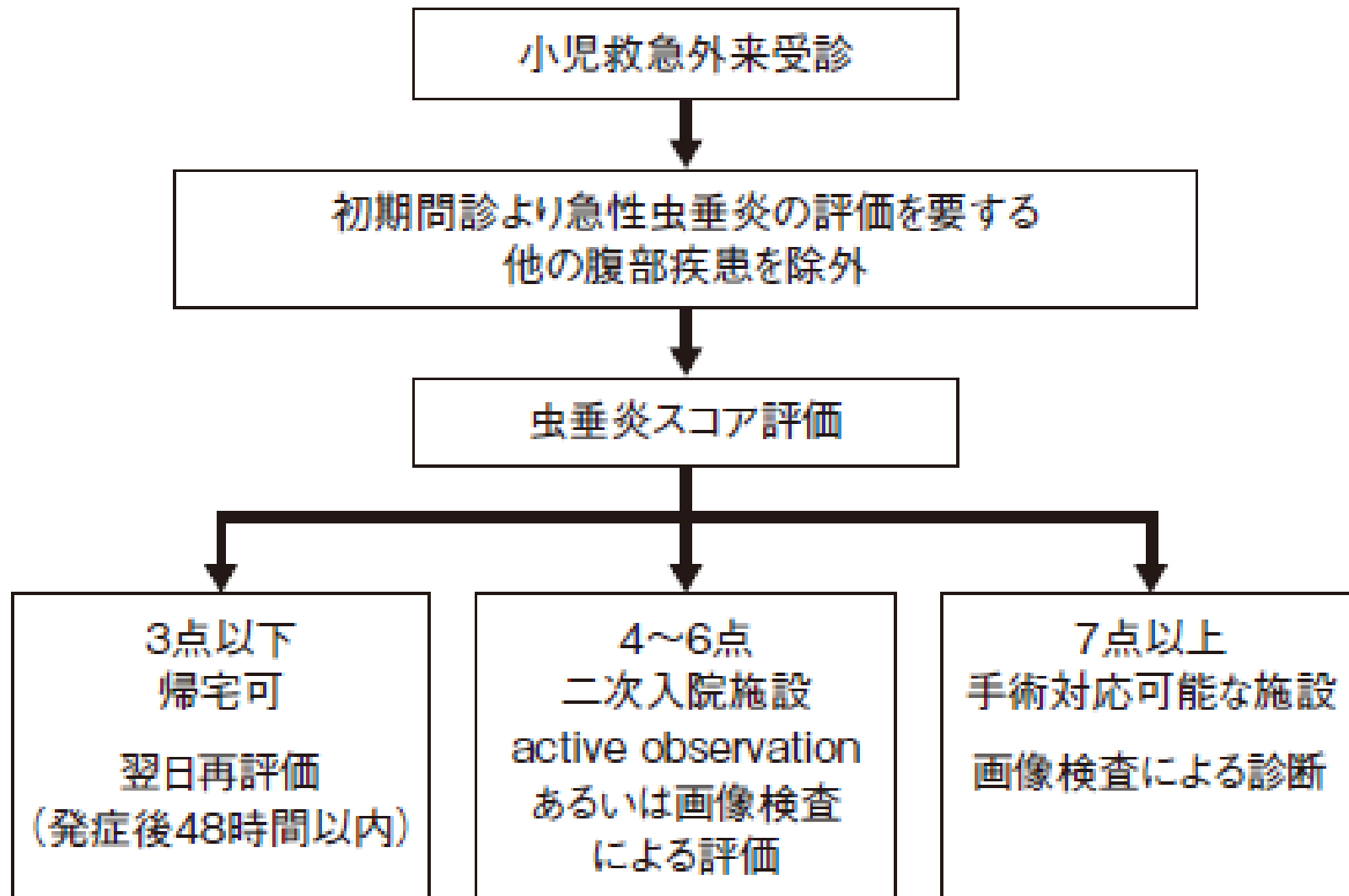
白血球数増加（10000/mm³以上）

1

左方移動（好中球7500/mm³以上）

1

スコアリングの点数の評価

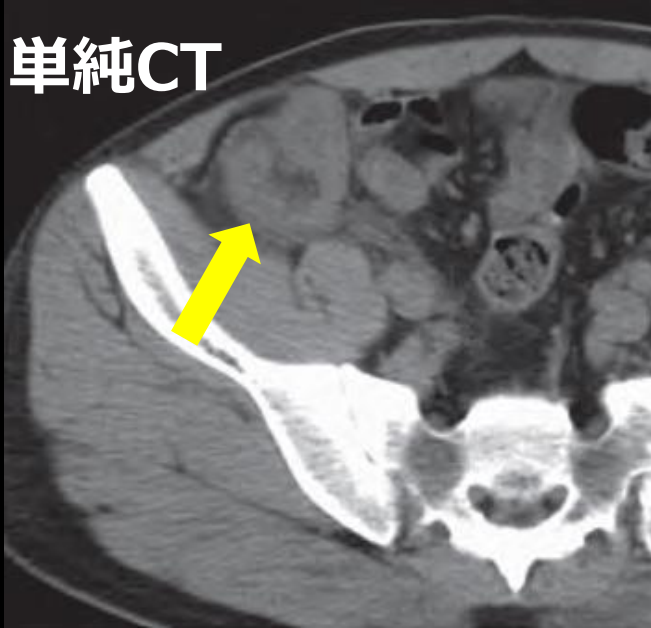


※Active observation

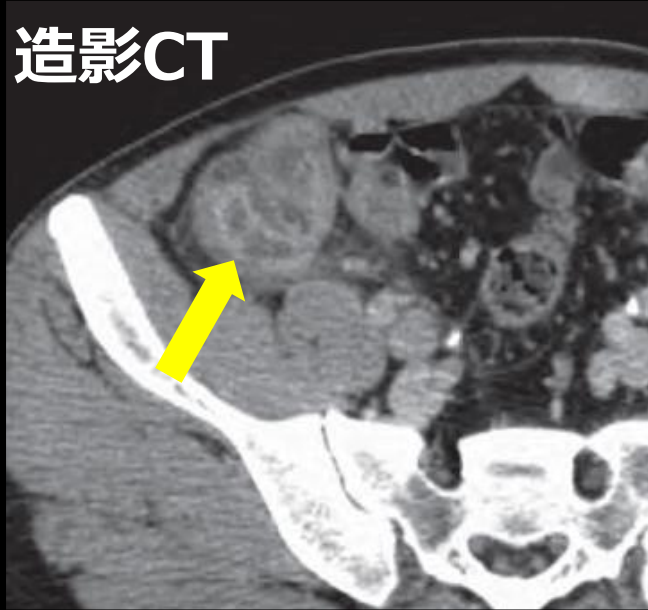
輸液を行い経口摂取禁で4～8時間ごとに身体所見、スコア、白血球数、CRP、エコー検査などで再評価を繰り返すこと。

虫垂炎のCT所見

単純CT



造影CT

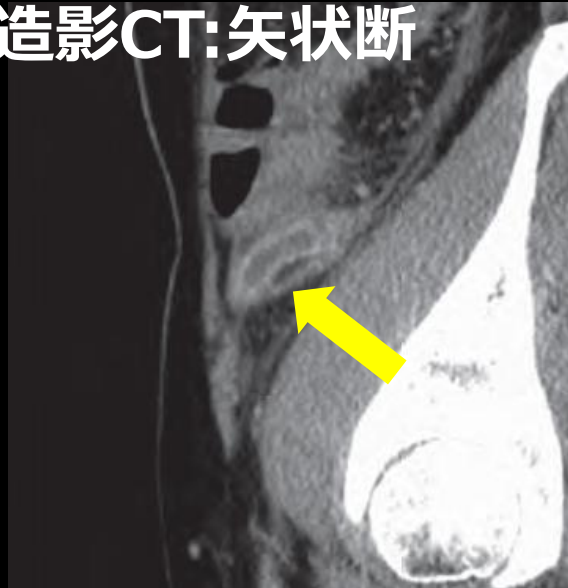


腫大した虫垂
(直径 $>7\text{mm}$)。
壁濃染と
壁肥厚を認める。

造影CT:冠状断

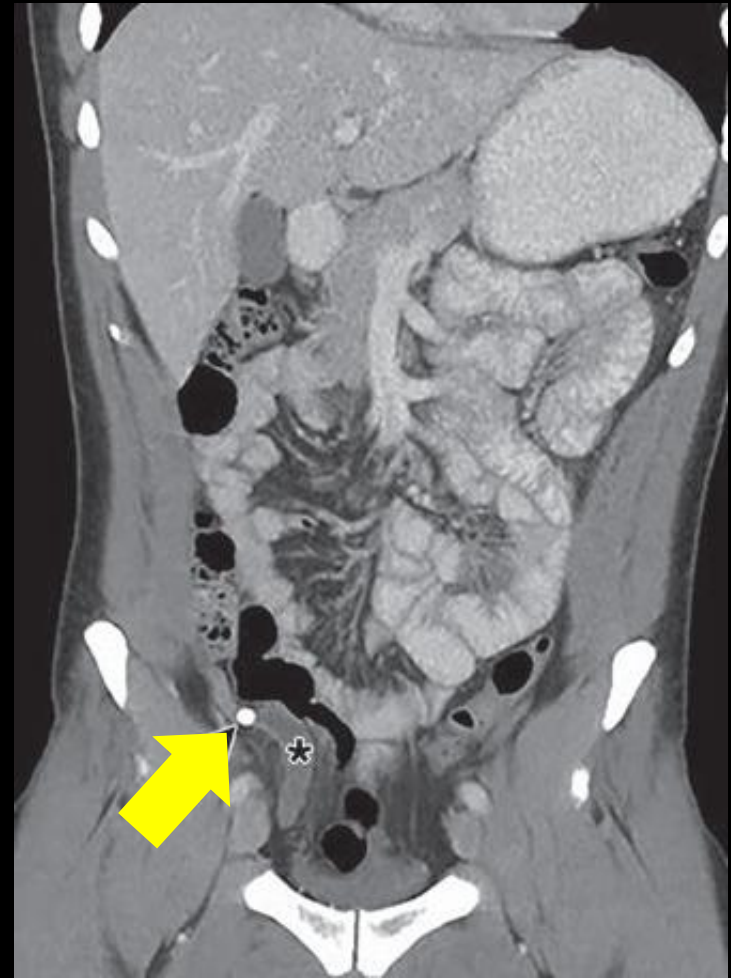
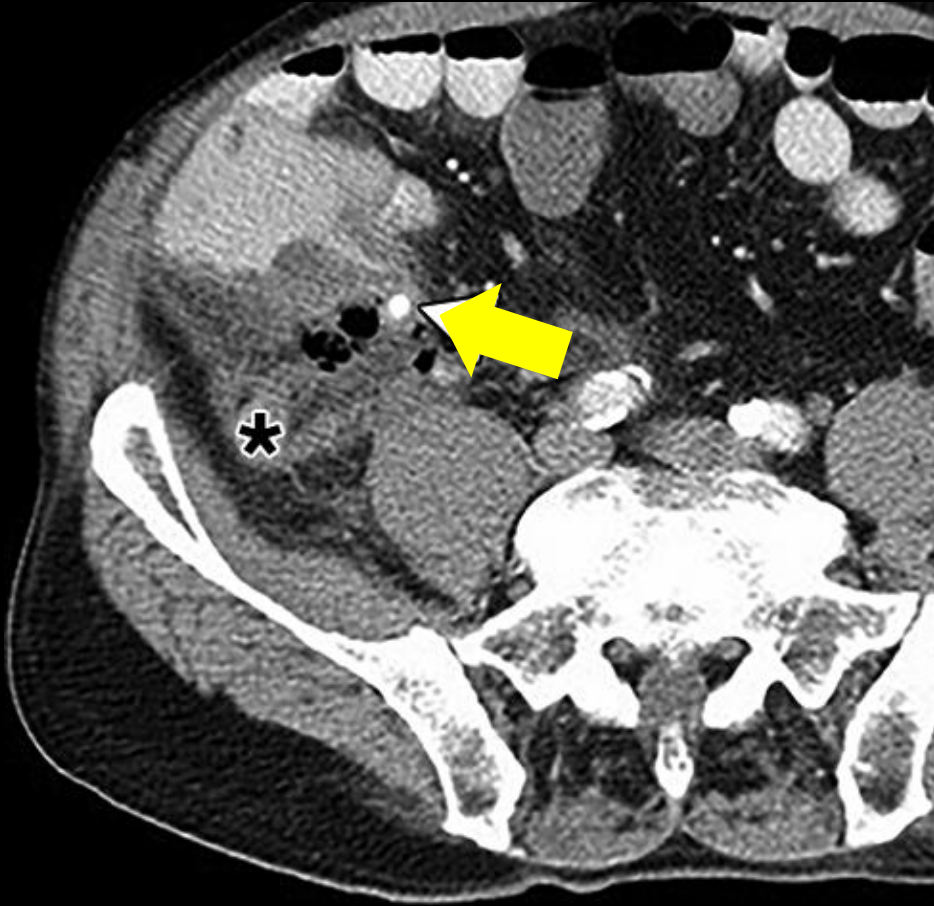


造影CT:矢状断

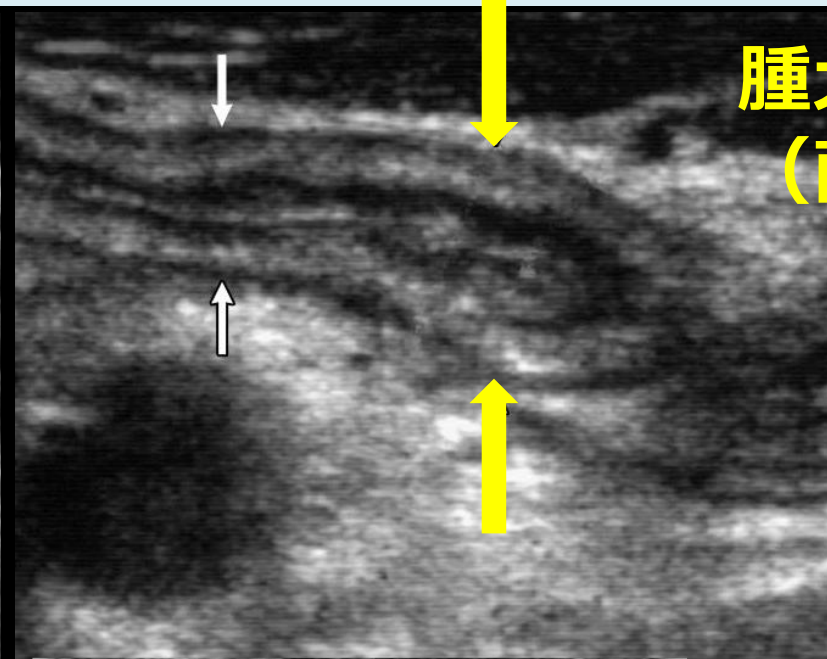
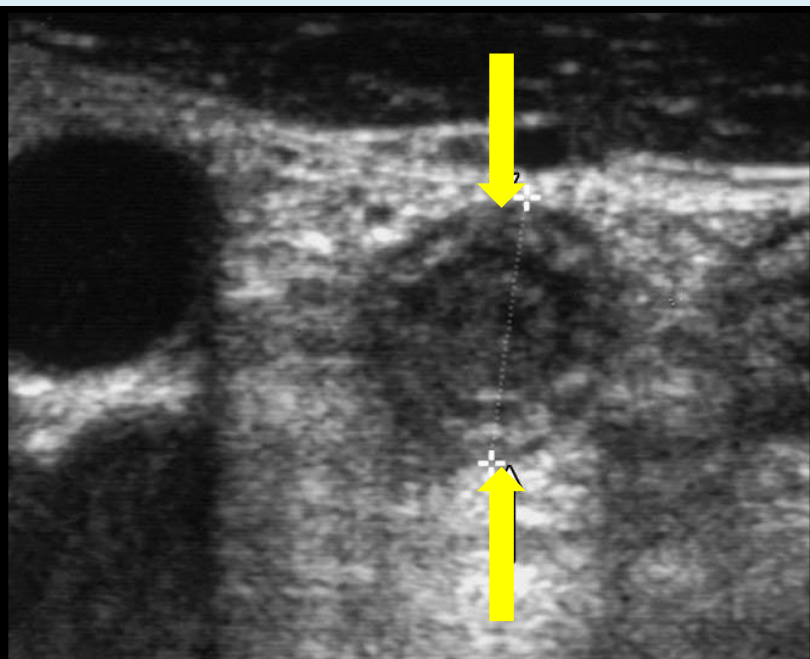


画像診断ガイドライン2016

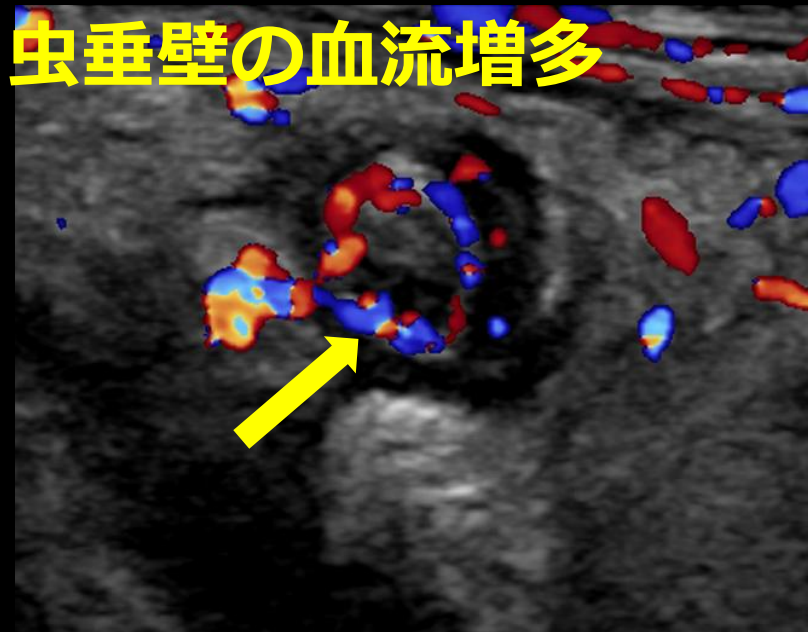
虫垂結石



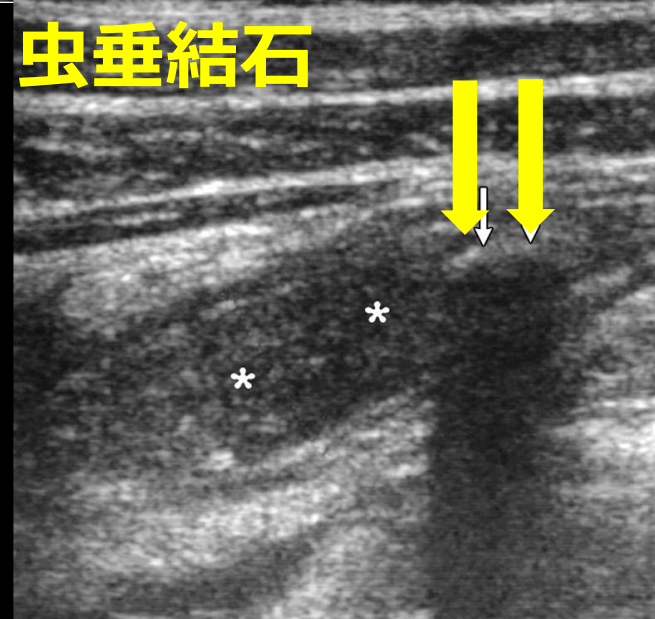
虫垂炎のエコー所見



腫大した虫垂
(直径 > 7mm)



虫垂壁の血流増多



虫垂結石

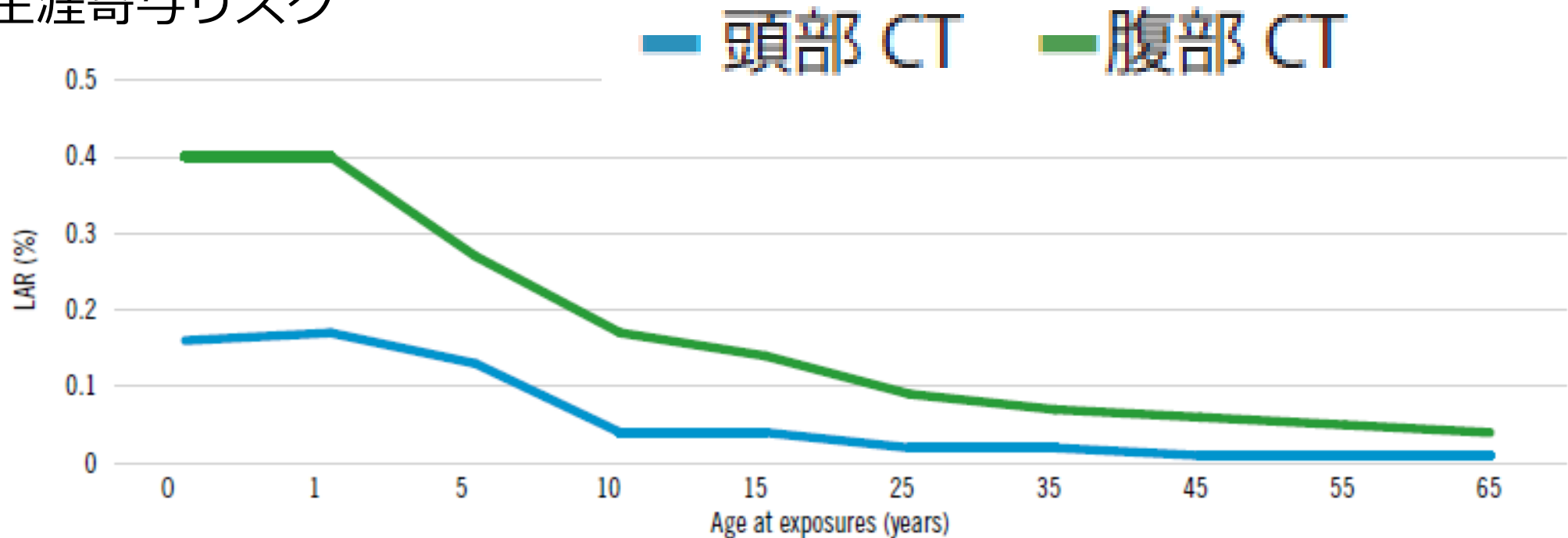
Radiology 2004; 230:472-478
J Med Radiat Sci 63 (2016) 59-66

画像検査における実効線量

診断方法	自然放射線への被ばく 相当期間※ (単純PA像)	標準的な実効線 量 (mSv)
胸部X線撮影		
5歳児	3日間	0.02
腹部CT		
成人	3年間	7
新生児	2.2年間	5.3
1歳児	1.8年間	4.2
5歳児	1.5年間	3.7
10歳児	1.5年間	3.7
※世界平均2.4 mSv/年に基づく		

CTによる放射線被ばくに関連する がん発生の生涯寄与リスク

がん発生の
生涯寄与リスク



※一般人口におけるがん発症率：42%
1歳児が腹部CT1回撮影→%

小児急性虫垂炎診断での超音波検査、CT検査の役割は？

小児急性虫垂炎の診断においては**原則として超音波検査を第一選択とする**のが望ましい。（推奨度A）

行うよう強く勧められる。
強い根拠があり、
臨床上明らかに有効である。

超音波検査が技術的に難しい場合や感度の低い場合（肥満、年少児など）、穿孔が疑われる場合には必要に応じてCT検査を考慮する。**感度を高め、被曝を軽減するためには1回の造影CTが望ましいが、造影剤による副反応には十分に注意する。**（推奨度B）

行うよう勧められる。
中等度の根拠があり、
臨床上有効性が期待できる。

虫垂炎の治療選択

- 複雑性虫垂炎

壊疽性／穿孔・汎発性腹膜炎⇒緊急手術

穿孔・膿瘍形成性（炎症性腫瘍や限局性膿瘍形成）

⇒Interval appendectomy

抗菌薬治療を先行し、8～20週後に待機的に手術

- 単純性虫垂炎⇒深夜の緊急手術は不要。

保存的治療も選択しうるが、再発に留意。

保存的治療（抗菌薬治療）の成績

報告者	報告年	対象基準	対象数	初期成功率	遠隔期再発率
鎌形	2010	US：壁不整なし 壁不整＋血流あり	94	95%	25%
Kaneko	2004	US：壁不整なし	24	100%	27%
黒田	2004	US：壁不整なし	32	100%	10%

今日の内容

急性胃腸炎

虫垂炎

解剖学的異常・通過障害

- ・ 腸回転異常症
- ・ メッケル憩室
- ・ 鎖肛

機能的消化管疾患

- ・ 周期性嘔吐症
- ・ 便秘症
- ・ ヒルシュスプルング病

腸重積症

腸回転異常: Intestinal Malrotation

<概念>

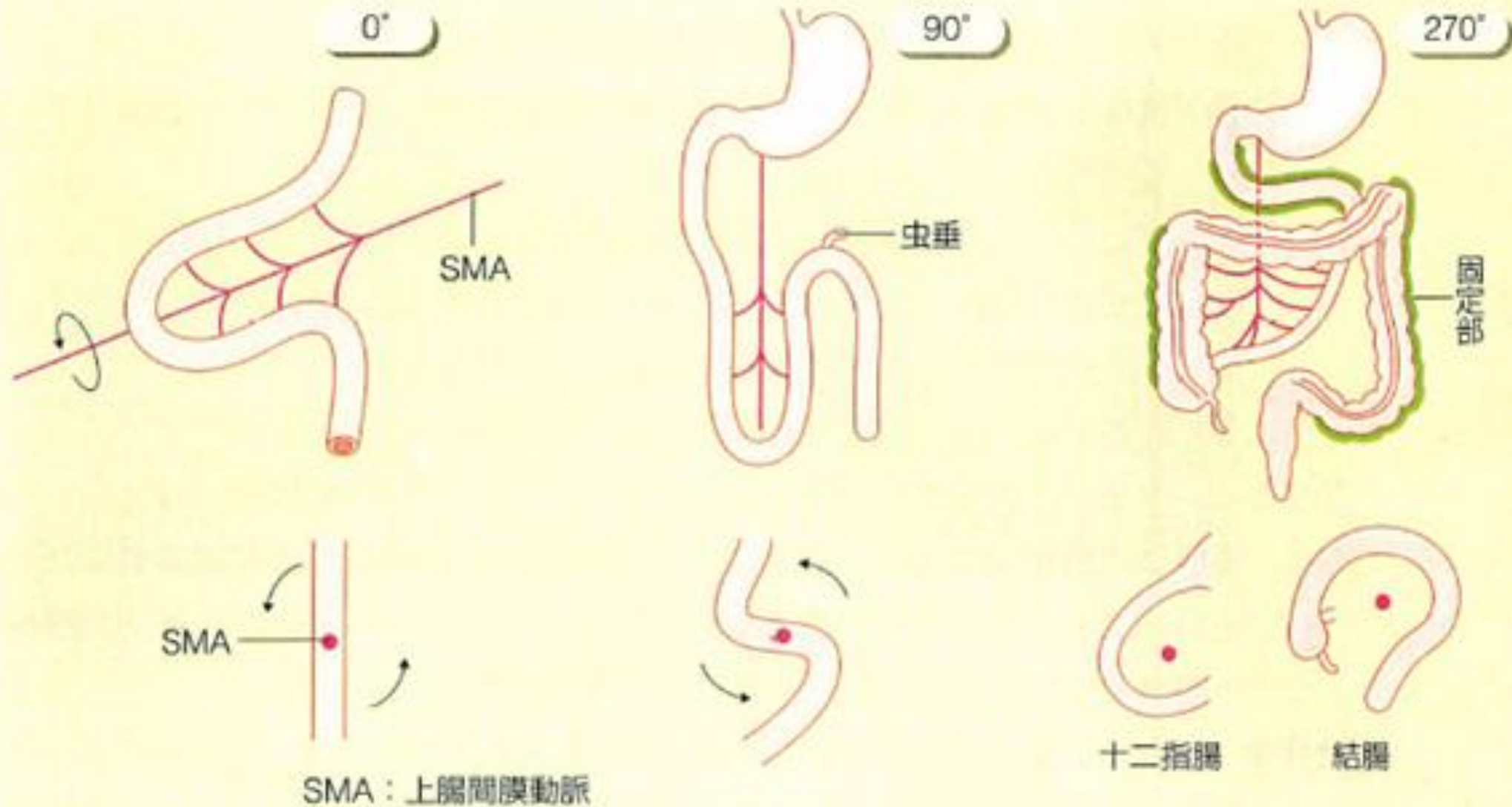
- 中腸（十二指腸のVater乳頭から横行結腸の脾弯曲まで）は、胎生11週から12週までに270度反時計方向に回転したあと、十二指腸と結腸が固定される。この過程の異常により生じる。
- 腸管の固定異常に起因する**十二指腸の通過障害**と、**中腸軸捻転**の症状を呈する。
- 新生児期・乳児期の発症が多いが、幼児期以降の発症例もある。

<疫学> 6000～8000人に1人の頻度。

<症状>

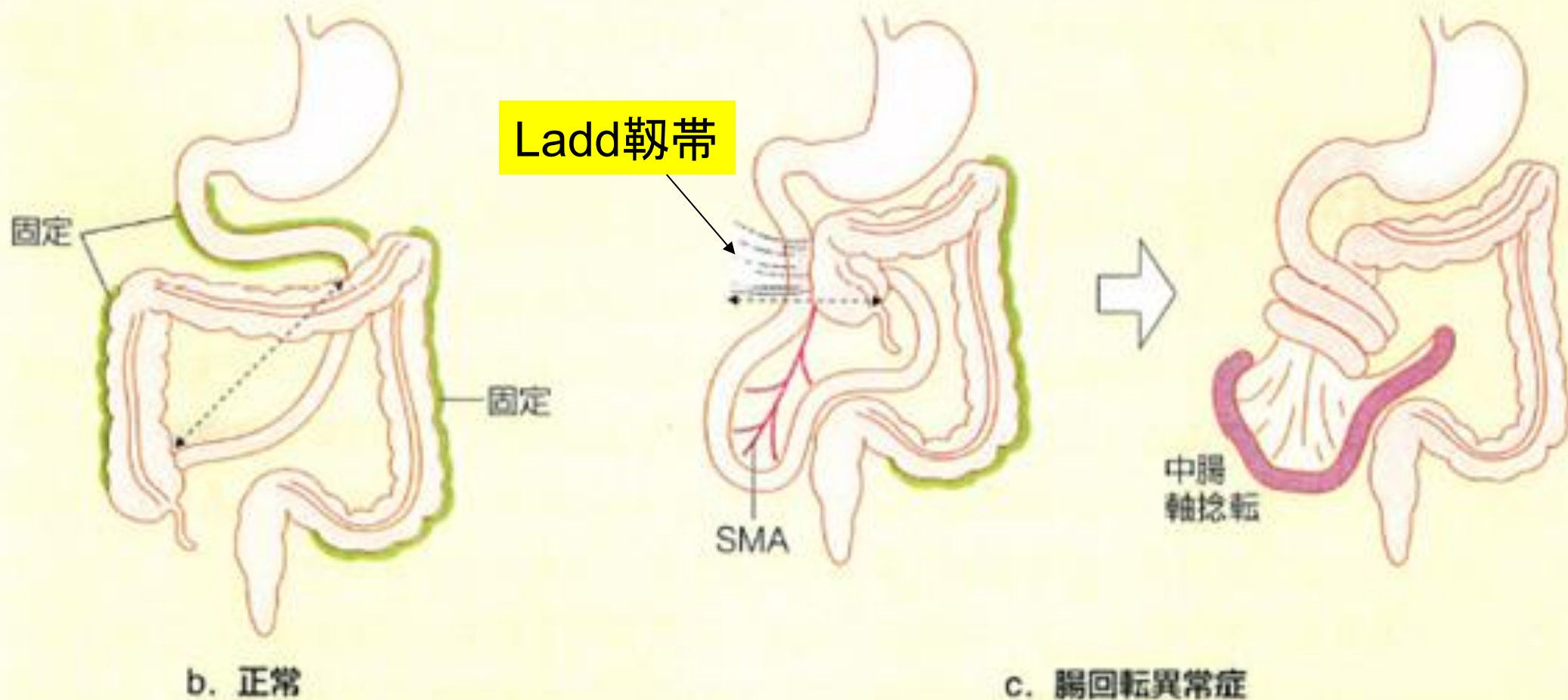
- 嘔吐・腹痛。
- 嘔吐は通常 で、中腸軸捻転をおこすと 。

正常腸回転



a. 正常腸回転：SMAを中心に、反時計方向に270° 回転して固定される。

腸回転異常に伴う中腸軸捻転



正常例に対し固定が不十分で小腸起始部と、末端の軸が狭い(図中・-----・)ため同部で軸捻転をおこす。捻転はSMAを巻き込み、広範囲腸管壊死をひきおこす。

腸回転異常症

<診断>

- 腹部単純X線撮影、上部消化管造影、注腸造影・腹部超音波検査。
- 中腸軸捻転を伴うと、カラードップルで上腸間膜動脈を中心に上腸間膜静脈が渦巻き状に描出される sign

Whirlpool sign



<治療> 中腸軸捻転伴う場合は緊急手術。

<予後> 中腸軸捻転は血行障害から広範囲腸管壊死・穿孔をきたしやすく、腸切除が必要な場合は救命しても短腸症となることがある。

メッケル憩室：Meckel Diverticulum

<概念>

- 回腸にみられる袋状の突起物で、胃や脾臓に似た組織を含む。
- 胎児期に臍帯と小腸との間に存在していた卵黄管が遺残したもの。

<疫学> 全人口の約2%にみられ、そのうち約20%が症状を呈する。

<症状>

- 憩室自体は無症状。
- 合併症により症状を呈する。

異所性胃粘膜による潰瘍形成⇒

腸閉塞⇒

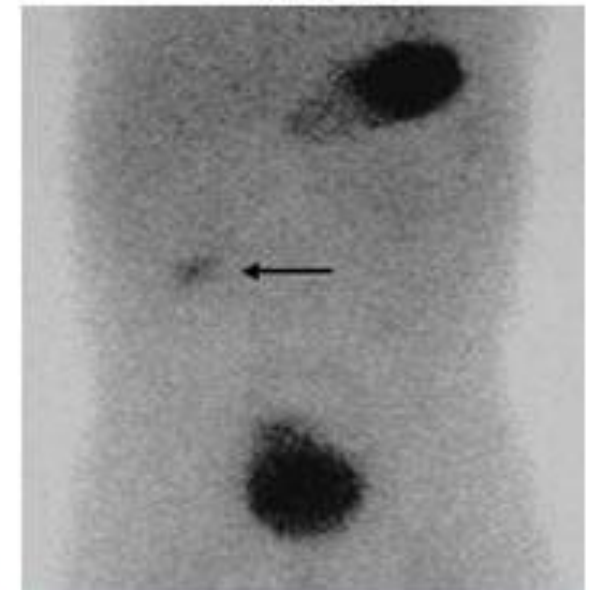
<診断> シンチグラム（異所性胃粘膜に集積）

<治療> 合併症があれば摘出術。

メッケル憩室



99mTc シンチ



鎖肛：Anal atresia

＜概念＞ 正常の肛門が形成されない先天性疾患。

＜疫学＞ 約5000出生に1人。

＜合併症＞ 約半数の症例で合併奇形（泌尿生殖器疾患・脊椎異常・心奇形・神経筋疾患・染色体異常など）。

- 瘻孔（直腸と膀胱や尿道、子宮、膣とのつながり）が存在することもある。

＜診断＞

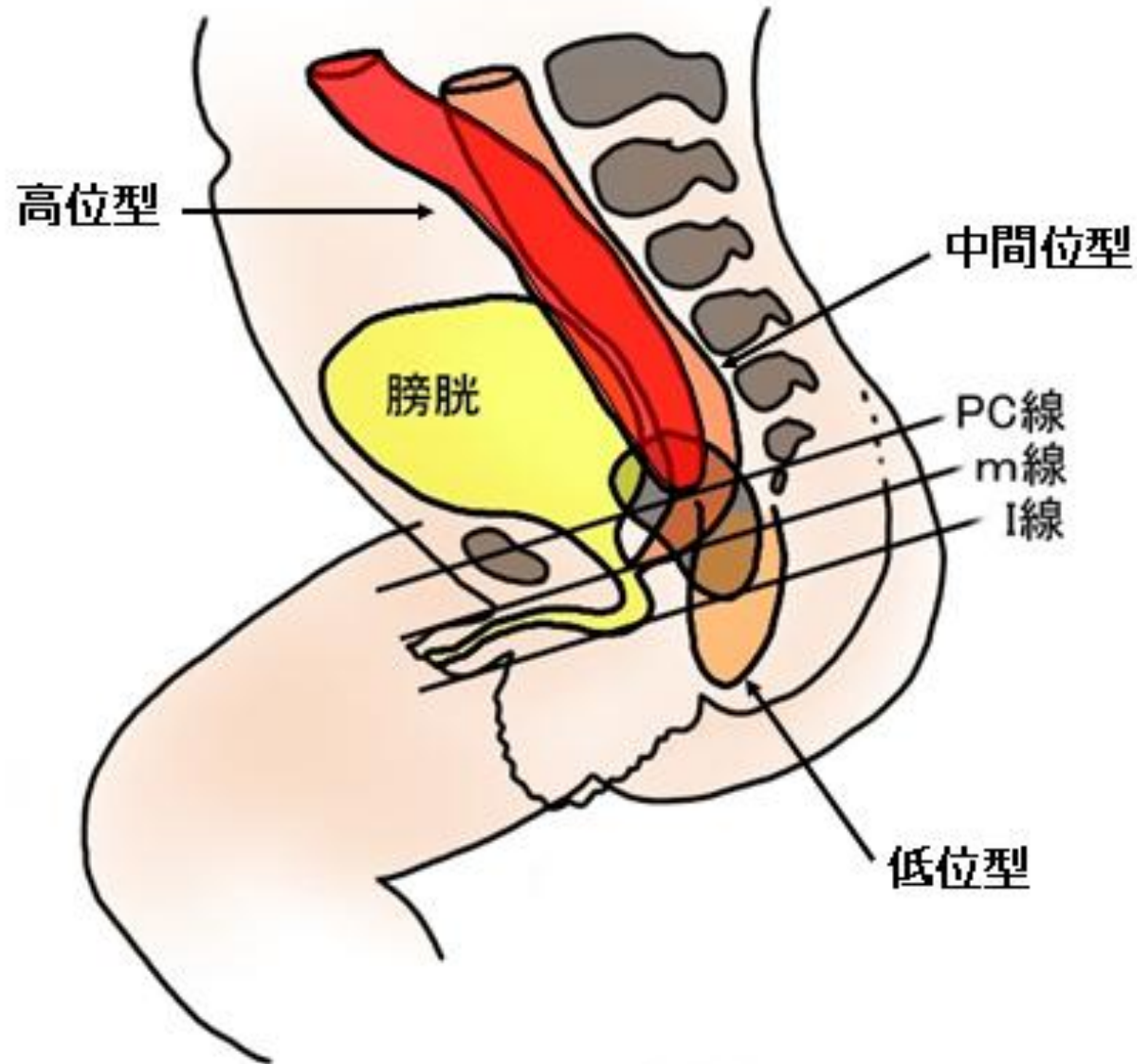
- 視診で診断。
- 撮影や、瘻孔からの造影検査で直腸盲端の位置を確認。

＜病型＞

- 低位、中間位、高位

鎖肛の病型分類

直腸末端の位置により分類



鎖肛

＜治療＞ 肛門形成術。

低位型：新生児～乳児期に肛門形成。

中間位・高位型：新生児期に人工肛門を造設。乳児期に肛門形成。

＜予後＞

- 生命予後は良好。
- 術後排便機能は低位型では良好。
- 高位型では骨盤底筋群の低形成のため、根治術後も便秘・失禁・汚染などが問題となることがある。

今日の内容

急性胃腸炎

虫垂炎

解剖学的異常・通過障害

- ・ 腸回転異常症
- ・ メッケル憩室
- ・ 鎖肛

機能的消化管疾患

- ・ 周期性嘔吐症
- ・ 便秘症
- ・ ヒルシュスプルング病

腸重積症

周期性嘔吐症候群

＜概念＞ 嘔吐を1時間～数日間繰り返す
間欠期は健康。 **数年の経過で自然治癒。**

＜疫学＞ **2～5歳に好発。**

＜症状＞ 頻回の激しい嘔吐、悪心、腹痛、
食欲不振。1時間～数日持続する。

＜診断＞ 器質的な疾患を除外。

＜治療＞ 対症療法 。

＜予後＞ のちに**偏頭痛**に移行することがある。

便秘症

定義

- 排便が週に□より少ない、□以上出ない、排便時に痛みや出血がある。

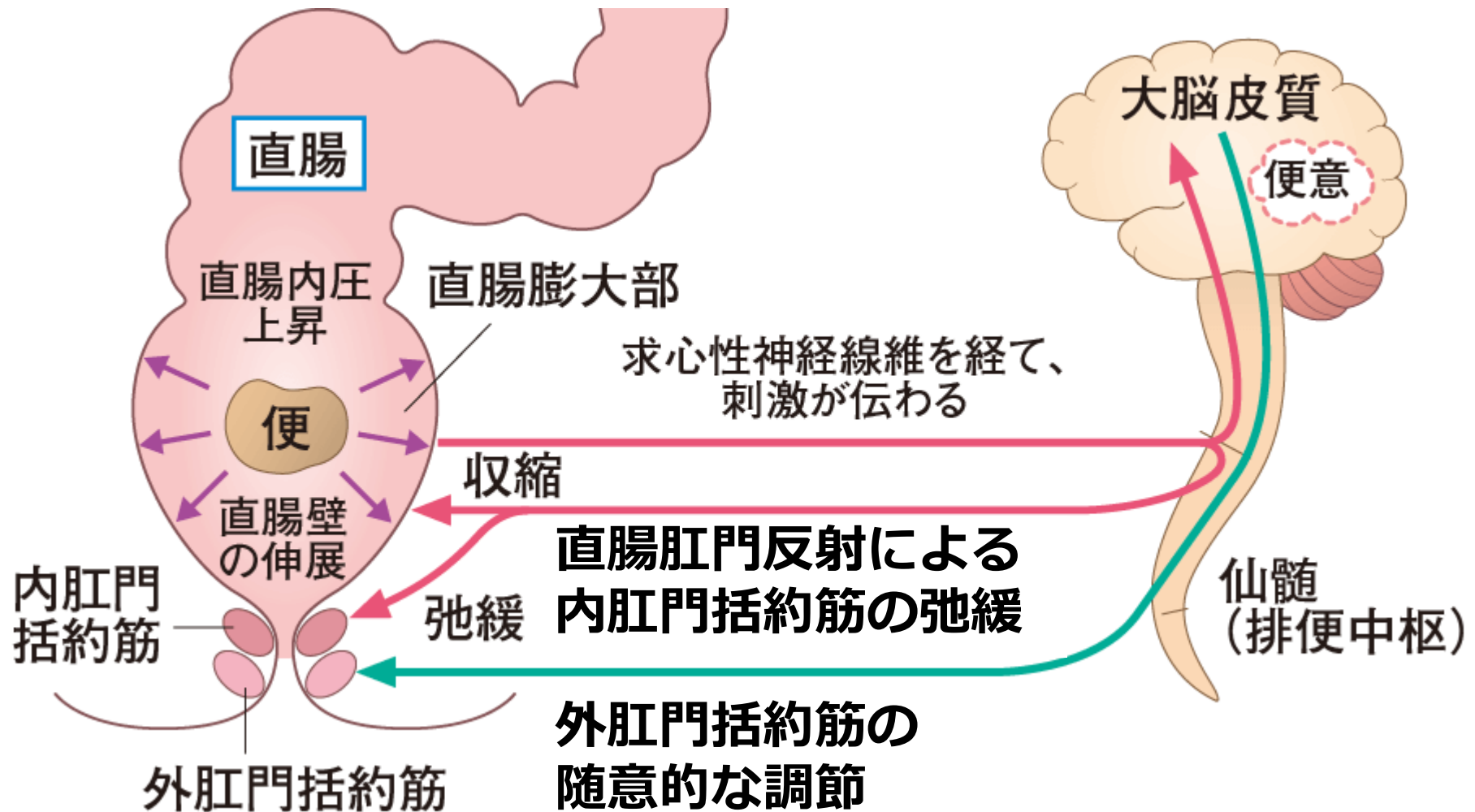
特徴

- 成人へ移行がしやすい。
- 再発しやすい。

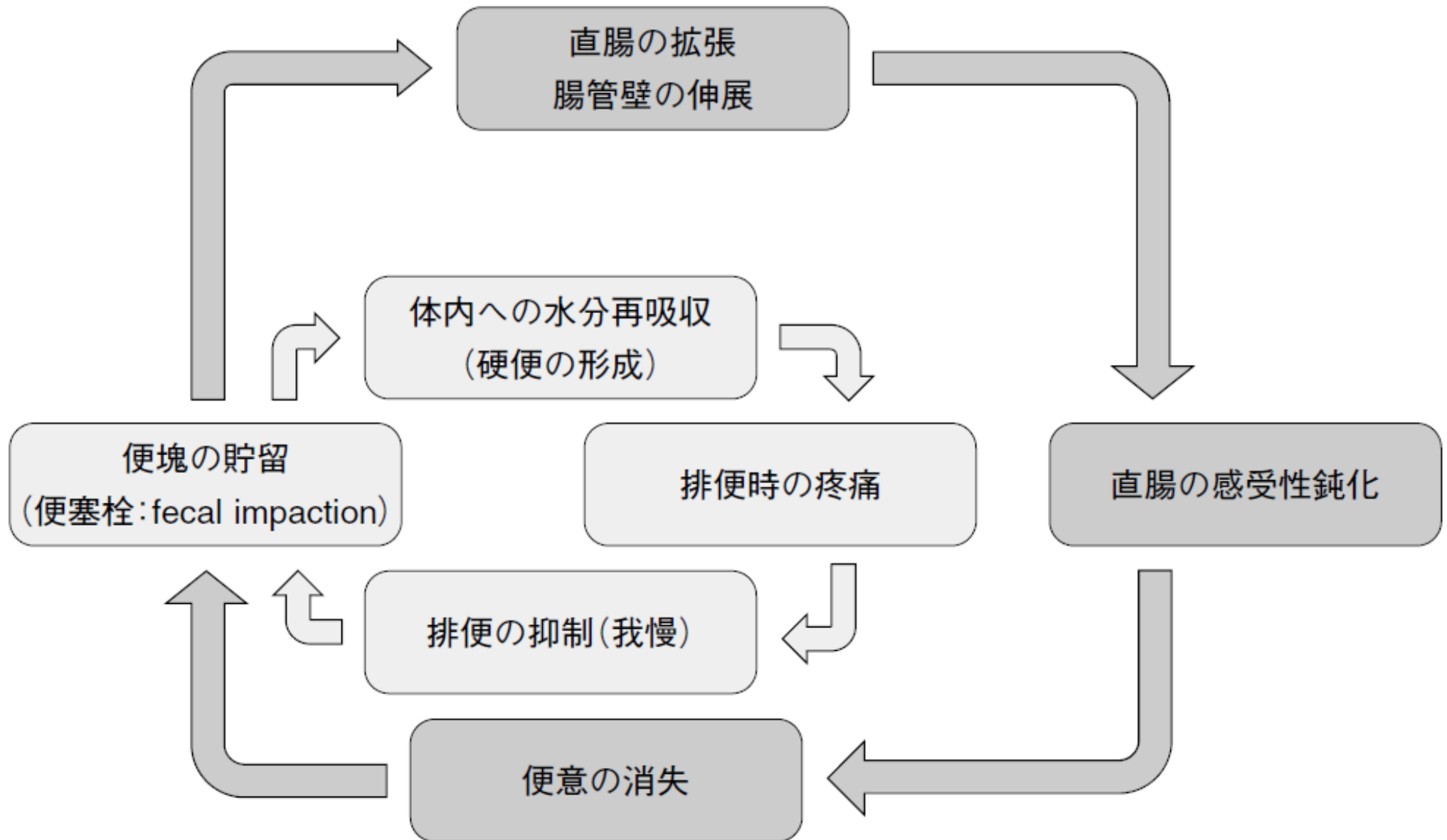
小児で便秘を発症しやすい時期

- 母乳から人工乳へ移行
- 乳児における離乳食の開始
- 幼児におけるトイレトレーニング
- 学童における通学の開始

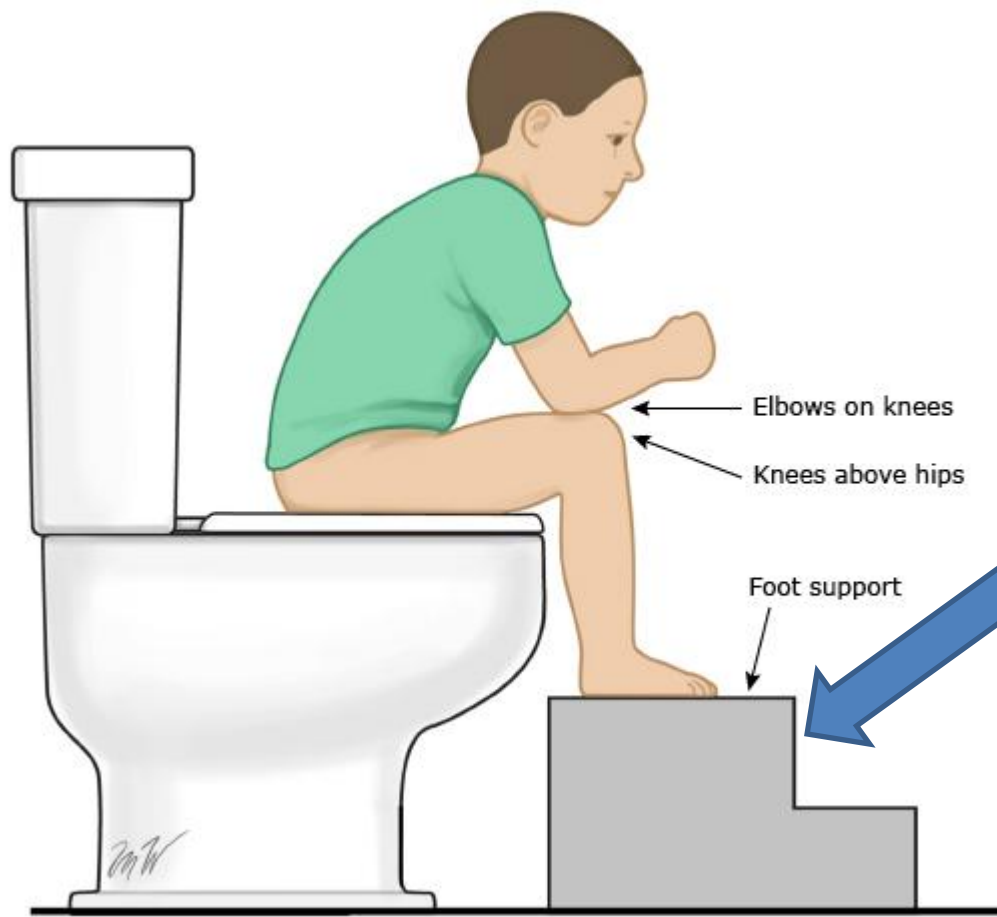
排便の仕組み



便秘の悪循環



排便しやすい姿勢



踏み台を使用する

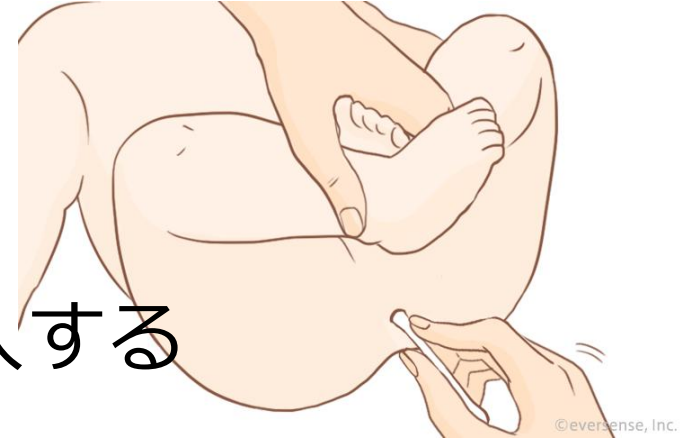
便秘の治療

- 溜まった便を出す（便塊除去）

浣腸、下剤

肛門刺激(新生児・乳児期)：

綿棒を肛門から1～2cm挿入する



- 維持療法

①生活習慣や排便習慣の改善

②食事療法

③薬物療法：浸透圧性下剤が第一選択

水分を腸管内に移動させる⇒便が軟らかくなる

ブリストルスケール

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | 硬くてコロコロの兔糞状の(排便困難な)便 |
| 2 |  | ソーセージ状であるが硬い便 |
| 3 |  | 表面にひび割れのあるソーセージ状の便 |
| 4 |  | 表面がなめらかで軟らかいソーセージ状、
あるいは蛇のようなとぐろを巻く便 |
| 5 |  | はっきりとしたしわのある軟らかい半分固
形の(容易に排便できる)便 |
| 6 |  | 境界がほぐれて、ふにゃふにゃの不定形の
小片便、泥状の便 |
| 7 | 全くの水状態 | 水様で、固形物を含まない液体状の便 |

1～2：便秘

3～5：正常便

6～7：下痢

ヒルシュスプルング病

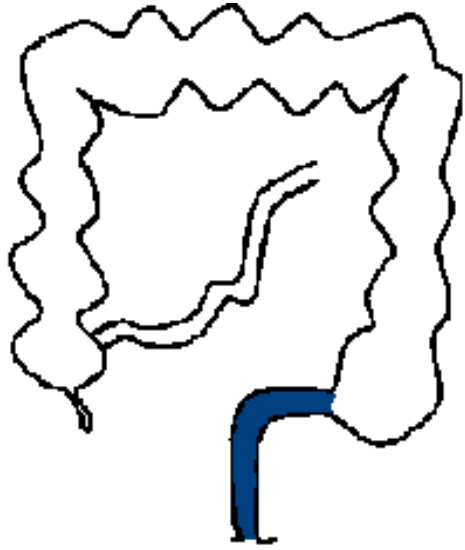
＜概念・定義＞

- 腸の の先天的欠如による。
- 腸管が正常な蠕動運動をできないため、
重い便秘症や腸閉塞をおこす。
- 頻度は約5000人に1人程度。
- 生後1か月までに約半数、1歳までにほとんどが診断される。

＜症状＞

- 胎便排泄遅延、腸閉塞症、排便不良、腹部膨満。

ヒルシュスプルング病の分類



短域無神経節症
(全体の80%)



長域無神経節症
(12%)

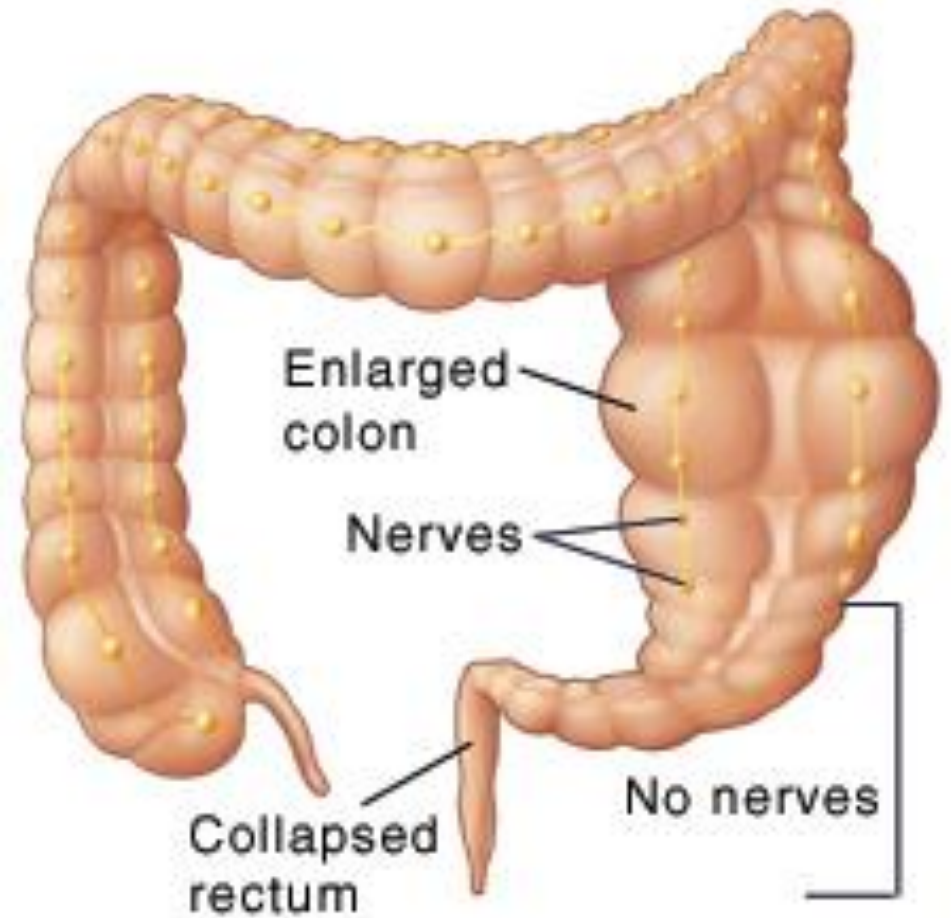


全結腸無神経節症
(5%)



広範囲無神経節症
(3.5%)

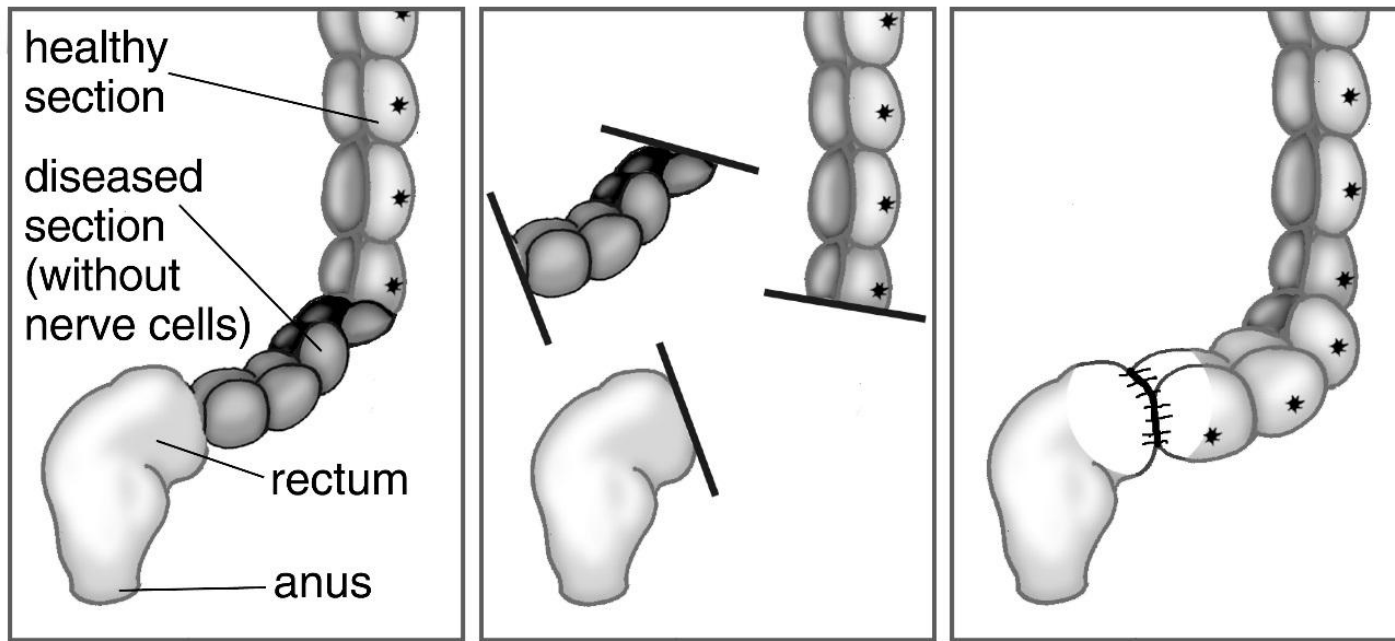
ヒルシュスプルング病の単純レントゲン



ヒルシュスプルング病の外科治療

<治療>

Pull-through手術



神経節細胞のない腸を切除し、正常の腸を肛門とつなげる。

<予後>

- ほぼ正常の排便機能になる。

今日の内容

急性胃腸炎

虫垂炎

解剖学的異常・通過障害

- ・ 腸回転異常症
- ・ メッケル憩室
- ・ 鎖肛

機能的消化管疾患

- ・ 周期性嘔吐症
- ・ 便秘症
- ・ ヒルシュスプルング病

腸重積症

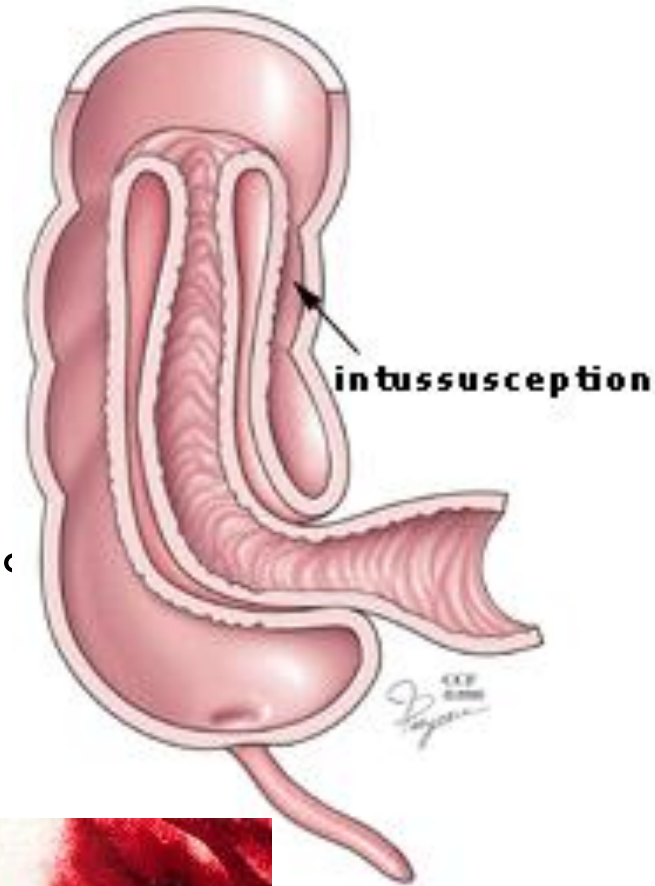
腸重積症

<概念>

- 腸管の一部が腸管の内腔に陥入・重積することでおこる。
- 重積した腸管は虚血、浮腫となり、診断が遅れると壊死、穿孔する。
- 生後3か月から2歳で好発。男児に多い。
- 誘因はウイルス感染、ロタウイルスワクチンなど。

<症状>

- 腹痛・血便・嘔吐。
- 数十分間隔の 腹痛。
- 様の血便。



腸重積の発症は7-8か月頃がピーク

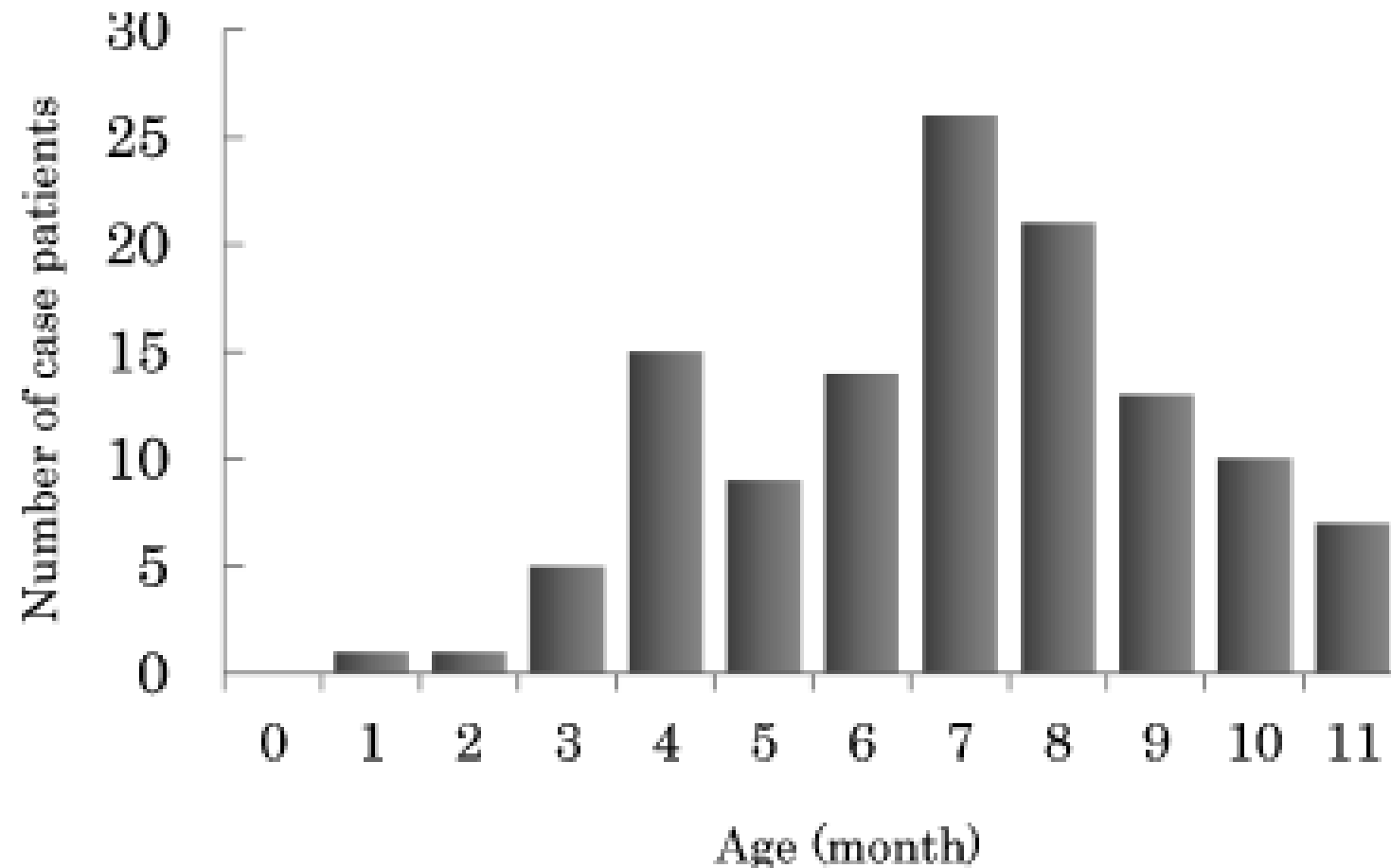
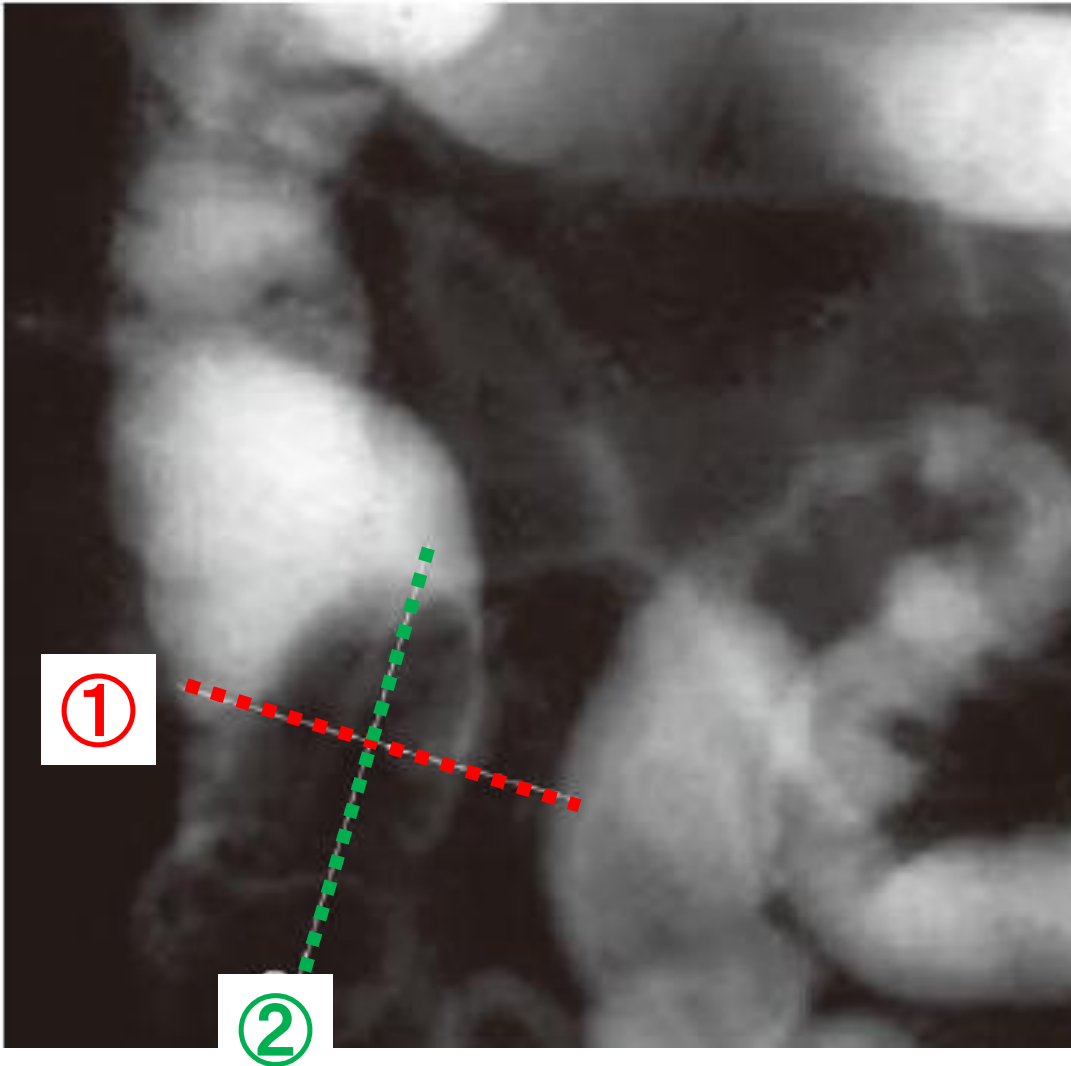


Fig. 2. Age distribution of intussusception patients among children younger than 1 year of age in Akita Prefecture, Japan, between 2001 and 2010.

腸重積の注腸像と超音波所見



エビデンスに基づいた小児腸重積症の診療ガイドラインより

腸重積症

<治療>

- 非観血的整復（注腸造影）

造影剤を自然落下で注腸、透視下に静水圧で陥入腸管を押し戻す。造影剤のかわりに空気を注入したり、透視のかわりに超音波を用いる方法もある。

- 観血的整復(緊急手術)。

Hutchinson手技：

注腸造影で整復不可能な例などで適応。

腸管壊死例では腸切除。

<予後>

- 良好。

